Perfil V3 · código por código

Urología

Los 62 códigos del Perfil de Conocimientos EUNACOM v3 (2026) de Urología, uno por uno: el nivel que exige el examen, dónde se enseña en nuestros libros, lo que hay que saber en resumen y una pregunta.

Niveles del Perfil — Diagnóstico: **Sospecha** (reconocer y derivar) o **Específico** (confirmar). Tratamiento: **Inicial** (estabilizar y derivar) o **Completo**. Seguimiento: **Derivar**, **Completo** o **No requiere**.

Situaciones clínicas 28 códigos

4.03.1.001 Balanitis, balano postitis

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: uro-16

QUÉ HAY QUE SABER

- Balanopostitis: inflamación de glande y prepucio con eritema, edema, prurito, secreción y mal olor; favorecida por fimosis, mala higiene, diabetes y obesidad.
- Etiología: Candida (la más frecuente, sobre todo en diabéticos: placas blanquecinas), bacteriana (estreptococo, anaerobios), irritativa o por ITS; en recurrentes pedir glicemia/HbA1c.
- Tratamiento: aseo con agua tibia y secado, retracción suave; candidiásica: clotrimazol 1% crema 2 veces al día por 7–14 días (o fluconazol 150 mg oral dosis única); bacteriana: antibiótico tópico u oral según clínica.
- Tratar a la pareja si es candidiásica recurrente o hay sospecha de ITS; descartar sífilis, herpes y VIH ante úlceras.
- Seguimiento: control de la respuesta y del factor predisponente; balanitis recurrente con fimosis es indicación de circuncisión.
- Lesión persistente, indurada o que no responde en 4–6 semanas: derivar para biopsia (liquen escleroso, eritroplasia de Queyrat, carcinoma).

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Hombre de 58 años, obeso, no circuncidado, consulta por ardor y prurito del glande de 2 semanas. Al examen se observa eritema del glande y del prepucio con pápulas satélites y un exudado blanquecino. No tiene secreción uretral. Nunca se ha controlado la glicemia. **Además del tratamiento tópico, ¿qué examen es más importante solicitar?**
>
> **A)** Glicemia en ayunas
> **B)** VDRL
> **C)** Cultivo de secreción uretral para gonococo
> **D)** Biopsia del glande
> **E)** Ecografía testicular
>
> Respuesta A. Eritema del glande con pápulas satélites y exudado blanquecino sugiere balanopostitis candidiásica, que se trata con antifúngico tópico (clotrimazol) e higiene. Es frecuente en diabéticos y puede ser su primera manifestación, por lo que debe solicitarse glicemia. La biopsia se reserva para lesiones persistentes pese a tratamiento.

4.03.1.002 Cáncer de próstata

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 13.8 Cáncer de Próstata: Tamizaje APE, Tacto Rectal, Biopsia y Score de Gleason · Tema 13.9 Cáncer de Próstata: Tratamiento según Riesgo (Cirugía, Radioterapia, Hormonoterapia)

QUÉ HAY QUE SABER

- Cáncer de próstata: el más frecuente en el hombre chileno; nace en la zona periférica posterior, por lo que en etapa precoz es asintomático y no obstruye.
- Factores de riesgo: edad (raro antes de 45–50 años), familiar de primer grado (duplica o triplica el riesgo, BRCA2) y ascendencia africana.
- Sospecha: nódulo pétreo, asimetría o próstata fija al tacto rectal (biopsia aunque el APE sea normal) o APE >4 ng/mL confirmado a las 4–6 semanas (tratar antes una ITU o prostatitis).
- Ajustes del APE: con finasteride/dutasteride >6 meses se multiplica por 2; relación libre/total <15% en zona gris 4–10 aumenta la sospecha.
- GES (desde 15 años): biopsia dentro de 30 días desde la sospecha fundada y tratamiento dentro de 60 días desde la confirmación.
- Seguimiento: derivar a urología; dolor óseo, APE muy alto y fosfatasas elevadas sugieren metástasis blásticas (cintigrama óseo).

PREGUNTAS (8)

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 103

Paciente de 83 años con APE 10, adenocarcinoma de próstata Gleason 3+3 en 0,3% de la muestra, estudio de diseminación negativo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Vigilancia activa con control en 3 meses
B) Prostatectomía radical
C) Radioterapia de haz externo
D) Braquiterapia prostática
E) Deprivación androgénica

Respuesta A. Tumor de bajo riesgo, mínimo, sin diseminación, en un adulto mayor: vigilancia activa.

Pregunta de práctica

Hombre de 61 años, asintomático. Tacto rectal normal. APE total de 6,2 ng/mL; descartada una infección urinaria, se repite a las 4 semanas: 6,4 ng/mL, con relación APE libre/total de 9%. **¿Cuál es la conducta diagnóstica más adecuada?**

A) Tamsulosina y control con APE en 1 año
B) Biopsia prostática guiada por ecografía transrectal
C) Cintigrama óseo de entrada
D) Finasteride por 6 meses para ver si el APE baja
E) Tranquilizar porque no hay nódulo

Respuesta B. APE confirmado en la zona gris con fracción libre de 9%, menor de 15%: alto riesgo de cáncer. Corresponde biopsia. El finasteride enmascararía el APE y retrasaría el diagnóstico.

Pregunta de práctica

La biopsia prostática informa: adenocarcinoma acinar con patrón Gleason primario 4 en 60% del tumor y patrón secundario 3 en 40%. **¿Cuál es el score de Gleason y el grupo ISUP?**

A) Gleason 3+4=7; ISUP 2
B) Gleason 4+3=7; ISUP 3
C) Gleason 4+4=8; ISUP 4
D) Gleason 3+3=6; ISUP 1
E) Gleason 4+5=9; ISUP 5

Respuesta B. El primer número es el patrón más abundante (4) y el segundo el siguiente (3): 4+3=7, grupo ISUP 3, de peor pronóstico que 3+4.

Pregunta de práctica

En relación con las garantías explícitas en salud para el cáncer de próstata en Chile, ¿cuál es el plazo máximo para realizar la confirmación diagnóstica con biopsia desde la sospecha clínica fundada? **¿Cuál es el plazo máximo?**

A) 10 días
B) 30 días
C) 60 días
D) 90 días
E) 180 días

Respuesta B. La biopsia se garantiza dentro de 30 días desde la sospecha. Una vez confirmada, el tratamiento primario comienza dentro de 60 días.

Pregunta de práctica

Hombre de 76 años con dolor lumbar de 2 meses que empeora de noche. Sin déficit neurológico. Próstata pétrea y fija. APE 145 ng/mL y fosfatasas alcalinas 420 U/L. El cintigrama óseo muestra múltiples focos hipercaptantes en columna, pelvis y fémures. **¿Cuál es el tratamiento de primera línea?**

A) Prostatectomía radical con linfadenectomía
B) Terapia de deprivación androgénica
C) Vigilancia activa con APE cada 3 meses
D) Radioterapia prostática exclusiva con intención curativa
E) Resección transuretral de próstata

Respuesta B. Cáncer de próstata metastásico óseo: el pilar es la deprivación androgénica, médica o quirúrgica. Si se usa un agonista de GnRH como leuprolide, se agrega bicalutamida inicial para evitar el flare.

Pregunta de práctica

Hombre de 58 años, activo, con expectativa de vida sobre 20 años. Adenocarcinoma ISUP 2 (Gleason 3+4=7) en 4 de 12 cilindros, APE 7,5 ng/mL, cT1c. TAC y cintigrama óseo sin metástasis. **¿Cuáles son las dos opciones curativas estándar?**

A) Prostatectomía radical o radioterapia externa
B) Quimioterapia con docetaxel o deprivación androgénica exclusiva
C) Vigilancia activa o cistectomía radical
D) Resección transuretral o tamsulosina
E) Inmunoterapia o castración quirúrgica inmediata

Respuesta A. Riesgo intermedio localizado en un paciente con larga expectativa de vida: prostatectomía radical o radioterapia externa, con sobrevida equivalente. La elección depende de los efectos secundarios.

Pregunta de práctica

Hombre de 73 años con cáncer de próstata metastásico óseo inicia leuprolide intramuscular mensual. **¿Por qué se prescribe bicalutamida los primeros 14 días?**

A) Prevenir la hepatotoxicidad aguda del leuprolide
B) Bloquear el brote inicial de testosterona que puede causar dolor óseo y compresión medular
C) Acelerar la eliminación renal del leuprolide
D) Evitar la hiponatremia por ADH
E) Prevenir la necrosis avascular de la cabeza femoral

Respuesta B. Los agonistas de GnRH producen un aumento transitorio de LH y testosterona los primeros 7 a 14 días (flare up). En metástasis vertebrales puede causar dolor intenso, retención urinaria o compresión medular, y se bloquea con un antiandrógeno.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 82 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 85 años se realiza un antígeno prostático específico, que resulta 10 mg/dl, razón por la cual es sometido a una biopsia prostática transrectal, que se informa como “presencia de adenocarcinoma prostático, Gleason 3+3, presente en el 0,5% del tejido. El estudio de diseminación resulta negativo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Prostatectomía radical
B) Radioterapia
C) Observar
D) Braquiterapia
E) Hormonoterapia

Respuesta C. Conducta / Tratamiento indicado: Observar (opción C). El screening de cáncer de próstata con APE se realiza entre los cincuenta y setenta años; se inicia a los cuarenta en pacientes con antecedentes familiares o mutaciones BRCA1, BRCA2 o síndrome de Lynch De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

4.03.1.003 Cáncer de vejiga y urotelio

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 13.12 Cáncer de Vejiga: Hematuria Macroscópica Silente, Cistoscopía & RTUV

QUÉ HAY QUE SABER

- Carcinoma urotelial (>90%): principal factor de riesgo el tabaco (riesgo 3–4 veces), además aminas aromáticas (tinturas, caucho), ciclofosfamida y radiación pélvica.
- Sospecha: hematuria macroscópica total, indolora, intermitente y con coágulos en fumador mayor de 50 años; que ceda sola no lo descarta. Síntomas irritativos refractarios sugieren carcinoma in situ.
- Primeras medidas: urocultivo para descartar ITU, función renal y derivación a urología para uro-TAC con fase excretora y cistoscopía (examen que confirma).
- La resección transuretral es diagnóstica y terapéutica; la muestra debe incluir detrusor para definir invasión muscular.
- No músculo invasivo (~75%): RTU + BCG o mitomicina intravesical (recidiva 50–70%); músculo invasivo (≥T2): cisplatino neoadyuvante y cistectomía radical.
- Seguimiento: derivar; requiere cistoscopías periódicas por el especialista. Hematuria con retención por coágulos: sonda 3 vías e irrigación.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 159

Paciente femenina, fumadora de 30 paquetes/año, presenta hematuria, con abundante coágulos de sangre. No presenta dolor, fiebre, ni otros síntomas. Se solicita un sedimento de orina, que muestra abundantes eritrocitos, sin bacterias. El diagnóstico más probable es: **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Cistitis hemorrágica
B) Cáncer de vejiga
C) Cáncer renal.
D) Tuberculosis renal
E) Infección urinaria

Respuesta B. El cáncer de vejiga es la causa más frecuente de hematuria monosintomática en el adulto, en especial en un fumador. Las otras opciones tienen otros síntomas.

Pregunta de práctica

Hombre de 62 años operado de resección transuretral de una masa vegetante vesical. La biopsia informa carcinoma urotelial de alto grado que infiltra la lámina propia, con músculo detrusor indemne en la muestra (T1). **¿Cuál es el tratamiento adyuvante de elección?**

A) Cistectomía radical inmediata con conducto ileal
B) Instilaciones intravesicales con BCG
C) Radioterapia pélvica externa
D) Quimioterapia sistémica MVAC por 6 ciclos
E) Observación sin terapia adicional

Respuesta B. Es un cáncer no músculo invasivo T1 de alto riesgo. Tras la resección completa, el tratamiento adyuvante estándar para reducir la recidiva y la progresión es el BCG intravesical. La cistectomía se reserva para falla del BCG o invasión muscular.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 77 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 67 años, fumador de 20 cigarrillos diarios, consulta por hematuria de 4 días de evolución, abundante, con coágulos. No ha presentado disuria, ni poliaquiuria, ni mal olor en la orina, ni dolor. Su examen de orina muestra abundantes eritrocitos por campo, sin

A) Cáncer renal
B) Cáncer de vejiga
C) Cáncer de uréter
D) Cáncer de próstata
E) Cistitis intersticial

Respuesta B. La hematuria monosintomática del adulto sugiere un cáncer de vejiga. El antecedente de fumar, también.

4.03.1.004 Criptorquídea

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 13.10 Cáncer de Testículo: Masas Indoloras, Marcadores (AFP, b-hCG, LDH) & Orquiectomía Radical

QUÉ HAY QUE SABER

- Criptorquidia: testículo que no está en el escroto ni se logra descender; diferenciar del testículo retráctil, que sí baja con la maniobra y no requiere cirugía.
- El descenso espontáneo ocurre casi siempre en los primeros 6 meses; examinar en cada control del lactante, con manos tibias y paciente relajado.
- Confirmación clínica: palpable (canal inguinal) o no palpable; la ecografía no es necesaria para decidir la cirugía.
- Bilateral no palpable, sobre todo con pene pequeño o hipospadias: descartar trastorno de diferenciación sexual (cariograma, 17-OH-progesterona y electrolitos por HSC perdedora de sal).
- Conducta: derivar a cirugía infantil para orquidopexia, idealmente entre 6 y 18 meses, para preservar fertilidad, facilitar el autoexamen y reducir riesgo de torsión.
- Seguimiento: riesgo de cáncer testicular 4–10 veces mayor aunque se opere; controles con examen testicular y enseñar autoexamen en la adolescencia.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Lactante de 9 meses en control de salud. Desde el nacimiento no se palpa el testículo derecho en el escroto; se palpa en el canal inguinal y no logra descenderse al escroto con maniobras suaves. El testículo izquierdo está en posición normal. Pene y meato normales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Observar hasta los 5 años, porque puede descender espontáneamente
B) Orquiectomía derecha inmediata
C) Tratamiento con gonadotrofina coriónica como terapia de elección y control en la pubertad
D) Derivar a cirugía infantil para orquidopexia, idealmente antes de los 12 a 18 meses de vida
E) Tranquilizar porque es un testículo retráctil

Respuesta D. El descenso espontáneo ocurre casi siempre en los primeros 6 meses. Un testículo no descendido después de esa edad se deriva para orquidopexia, idealmente entre los 6 y 18 meses, para preservar la fertilidad, facilitar el autoexamen y disminuir el riesgo de cáncer y torsión. El testículo retráctil, en cambio, sí desciende con la maniobra.

4.03.1.005 Disfunción sexual de causa orgánica

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: uro-16

QUÉ HAY QUE SABER

- Disfunción eréctil: incapacidad persistente (≥3 meses) de lograr o mantener una erección suficiente; la causa orgánica más frecuente es vascular (aterosclerosis), además diabetes, neuropatía, fármacos e hipogonadismo.
- Orienta a orgánica: inicio gradual, pérdida de erecciones matinales/nocturnas, factores de riesgo cardiovascular; es marcador precoz de enfermedad coronaria.
- Estudio: glicemia o HbA1c, perfil lipídico, testosterona total matinal (y LH/prolactina si está baja); revisar fármacos (tiazidas, betabloqueadores, ISRS, antiandrógenos).
- Tratamiento inicial: manejo de factores de riesgo (tabaco, obesidad, actividad física) e inhibidores de PDE5: sildenafil 50 mg 1 h antes o tadalafilo 10–20 mg a demanda (5 mg diario).
- Contraindicación absoluta: nitratos (hipotensión grave); precaución con alfabloqueadores y cardiopatía inestable.
- Seguimiento: control de respuesta y riesgo cardiovascular; derivar a urología si no responde a PDE5, hay enfermedad de Peyronie o hipogonadismo.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 112

Hombre de 55 años con disfunción eréctil de 6 meses de evolución, sin causa aparente. HTA controlada con enalapril. Sin síntomas de hipogonadismo. **¿Cuál es el tratamiento de primera línea?**

A) Inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 (sildenafil o tadalafil)
B) Testosterona intramuscular
C) Alprostadil intracavernoso
D) Prótesis de pene
E) Solo consejería psicológica

Respuesta A. Los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 son la primera línea en la disfunción eréctil orgánica (vascular, diabética). Están contraindicados con nitratos. La testosterona solo si hay hipogonadismo demostrado; alprostadil y prótesis son segunda y tercera línea. La disfunción eréctil es además un marcador de riesgo cardiovascular que debe evaluarse.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 49 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 63 años consulta por impotencia sexual de algunos meses de evolución, que ha avanzado. Tiene antecedente de diabetes de 20 años de evolución. Está preocupado, ya que le ha provocado problemas maritales. El tratamiento más adecuado es:

A) Inyecciones intracavernosas de papaverina
B) Yohimbina
C) Sildenafil
D) Prótesis peneana
E) Psicoterapia

Respuesta A. Es una pregunta difícil, ya que el sildenafil está contraindicado por el infarto reciente. De primera línea está el sildenafil, la apomorfina y los dispositivos de vacío (no recuerdo si salía apomorfina). De segunda línea, están las inyecciones intracavernosas de papaverina o prostaglandina. La última línea es la prótesis peneana. La yohimbina y la protsglandina tópica sirven, pero poco.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 32 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 68 años, con antecedente de hiperplasia prostática benigna, hipertensión arterial y diabetes, está en tratamiento con tamsulosina, atenolol, hidroclorotiazida, metformina y aspirina. Consulta por dificultades para lograr y mantener la erección, lo que le preocupa. ¿Qué fármaco puede ser el causante de estos síntomas?

A) Aspirina
B) Metformina
C) Hidroclorotiazida
D) Tamsulosina
E) Atenolol

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Atenolol (opción E). Ahora ya saben, el atenolol puede producir impotencia sexual.. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 107 · texto original del banco, sin revisar

Paciente adulto mayor que no lograba erección, libido se conservaba, temor a que su pareja lo deje ya que antes tenían encuentros 1-2 por semana. Conducta:

A) Sildenafil
B) Búsqueda de causa 2ria: tenía líbido conservada, no describe ansiedad ante su performance, me parece relevante descartar causas secundarias (p ej diabetes) antes de asumir q su problema es psicológico c. Terapia psicológica (justifiquen cada una)
C) Trastorno de ansiedad generalizada
D) Trastorno obsesivo compulsivo
E) Trastorno de estrés postraumático

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Sildenafil (opción A). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención. Las opciones alternativas (Búsqueda de causa 2ria: tenía líbido conserva, Trastorno de ansiedad generalizada) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciale

4.03.1.006 Enfermedades de transmisión sexual

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 13.6 Orquiepididimitis Aguda: Etiología según Edad (<35 años ETS vs >35 años E. coli) & Manejo

QUÉ HAY QUE SABER

- Uretritis gonocócica: secreción purulenta abundante, incubación 2–7 días; Gram con diplococos Gram negativos intracelulares. No gonocócica (Chlamydia): secreción escasa, 'gota matinal', Gram solo con PMN.
- Toda uretritis: doble cobertura por coinfección 20–40%: ceftriaxona 500 mg IM dosis única + doxiciclina 100 mg c/12 h por 7 días (o azitromicina 1 g oral). Ciprofloxacino no, por resistencia del gonococo.
- Úlcera indolora, indurada, de fondo limpio con adenopatía indolora: sífilis primaria, penicilina benzatina 2.400.000 UI IM dosis única. Vesículas dolorosas en racimo: herpes, aciclovir 400 mg c/8 h 7–10 días.
- Úlcera dolorosa, sucia, con bubón: chancroide, azitromicina 1 g oral o ceftriaxona 250 mg IM. Condilomas (VPH 6 y 11): podofilotoxina, imiquimod o crioterapia.
- Ante toda ITS: tamizaje de VIH, sífilis y hepatitis B; tratar a los contactos de los últimos 60 días y abstinencia por 7 días; notificación obligatoria de las que corresponda.
- Seguimiento: control clínico y serológico (VDRL a los 3, 6 y 12 meses en sífilis), consejería en preservativo.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 30 años consulta por una úlcera en el glande de 10 días, indolora, de bordes indurados y fondo limpio, de 1 cm, con adenopatías inguinales bilaterales firmes e indoloras. Tuvo relaciones sexuales sin preservativo hace 4 semanas. No es alérgico a medicamentos. VDRL reactivo 1:16. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A) Penicilina benzatina 2.400.000 UI intramuscular por una vez, más estudio de VIH y tratamiento de la pareja
B) Aciclovir 400 mg cada 8 horas por 7 días
C) Ceftriaxona 500 mg intramuscular más doxiciclina
D) Azitromicina 1 g oral por una vez
E) Penicilina sódica endovenosa por 14 días

Respuesta A. Úlcera genital única, indolora e indurada, con adenopatías inguinales indoloras, es un chancro de sífilis primaria. El tratamiento es penicilina benzatina 2.400.000 UI intramuscular en dosis única, con notificación, estudio de VIH y otras ITS, y tratamiento de los contactos. La penicilina sódica endovenosa es para neurosífilis.

4.03.1.007 Epididimitis

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 13.6 Orquiepididimitis Aguda: Etiología según Edad (<35 años ETS vs >35 años E. coli) & Manejo

QUÉ HAY QUE SABER

- Epididimitis: dolor escrotal subagudo (1–3 días), escroto rojo y caliente, fiebre y síntomas urinarios; epidídimo engrosado desde la cola, Prehn positivo y reflejo cremastérico conservado.
- La edad decide el germen: menor de 35 años sexualmente activo, Chlamydia y gonococo; mayor de 35 o con patología prostática, E. coli y entéricos.
- Menor de 35: ceftriaxona 500 mg IM dosis única + doxiciclina 100 mg c/12 h por 10–14 días y tratar a la pareja.
- Mayor de 35: ciprofloxacino 500 mg c/12 h o levofloxacino 500 mg/día por 10–14 días y estudiar la vía urinaria baja (HPB, obstrucción). Siempre reposo, suspensorio y AINE.
- Ante duda con torsión (adolescente, inicio brusco, cremastérico abolido): exploración quirúrgica.
- Seguimiento: si persiste fiebre a las 48–72 h, eco Doppler para buscar absceso o infarto (derivar a urología para drenaje).

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 179

Un paciente de 60 años fue tratado hace 7 días con ciprofloxacino, por disuria. Hace dos días presenta dolor testicular izquierdo, asociado a fiebre. Al examen físico tiene aumento de volumen testicular, con dolor a la palpación, especialmente del conducto espermático. Se observa ligero edema escrotal, con eritema. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hidrocele
B) Varicocele
C) Torsión testicular
D) Tumor testicular
E) Orquiepididimitis

Respuesta E. Un varón de 60 años con infección urinaria reciente, fiebre y dolor testicular con edema y eritema escrotal: orquiepididimitis clásica. Se distingue de la torsión por la edad, la fiebre y el inicio subagudo.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 175

Un paciente de 65 años consulta por dolor escrotal derecho de 3 días de evolución. Al examen físico presenta dolor y eritema en la zona escrotal derecha y se palpa aumento de volumen y dolor, del testículo y del epidídimo. Refiere tener pareja sexual monogámica. **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A) Streptococcus pyogenes
B) Staphilococcus aureus
C) Chlamydia trachomatis
D) Neisseria gonorreae
E) Escherichia coli

Respuesta E. En mayores de 35 años, y sin conducta sexual de riesgo, la orquiepididimitis la causa más frecuente es E. coli, por reflujo desde la vía urinaria.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 161

Un paciente de 21 años, sexualmente activo, consulta por dolor y aumento de volumen progresivos en relación al testículo izquierdo, que inició hace 5 días y se ha asociado a disuria y escasa secreción uretral. Al examen físico, presenta frecuencia cardíaca 65 latidos por minuto, presión arterial 110/70 mmHg y temperatura axilar de 37,1 °C. El examen genital muestra escroto aumentado de volumen y enrojecido a izquierda; se palpa testículo izquierdo ligeramente aumentado de volumen, sin masas, y epidídimo izquierdo con gran aumento de volumen, muy doloroso a la palpación. **¿Qué tratamiento es el más adecuado?**

A) Ceftriaxona intramuscular
B) Ciprofloxacino oral
C) Amoxicilina con ácido clavulánico oral
D) Doxiciclina oral
E) Exploración quirúrgica

Respuesta D. Orquiepididimitis con uretritis en un joven sexualmente activo, de curso subagudo y con escasa secreción: lo más probable es Chlamydia, que se trata con doxiciclina. En la práctica se cubren ambos gérmenes, con ceftriaxona más doxiciclina.

Pregunta de práctica

Hombre de 26 años, sexualmente activo sin preservativo, consulta por dolor progresivo en el hemiescroto derecho de 48 horas, con sensación febril y ardor al orinar. T° 37,9 °C. Hemiescroto tumefacto y caliente, epidídimo derecho engrosado y muy sensible. Reflejo cremastérico presente. Al elevar el testículo, el dolor se alivia. **¿Cuál es el manejo más adecuado?**

A) Exploración quirúrgica urgente
B) Ceftriaxona 500 mg IM más doxiciclina 100 mg cada 12 horas
C) Ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas en monoterapia
D) Reposo y AINE sin antibiótico
E) Doppler y esperar el resultado antes de tratar

Respuesta B. Epididimitis aguda en un menor de 35 años sexualmente activo: Prehn positivo y reflejo cremastérico presente. Se toman muestras y se inicia esquema dual con ceftriaxona y doxiciclina, más reposo, suspensorio y tratamiento de la pareja.

4.03.1.008 Estenosis uretral

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 13.2 Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía

QUÉ HAY QUE SABER

- Estenosis uretral: disminución progresiva del calibre y fuerza del chorro, disuria de esfuerzo, goteo e ITU recurrente en hombre joven o con antecedente de trauma perineal o pelviano, instrumentación, RTU o uretritis.
- Se sospecha cuando la sonda no progresa (típicamente en uretra bulbar) o produce uretrorragia; no forzar el sondeo.
- Estudio: uroflujometría (Qmáx bajo con curva aplanada en meseta) y uretrografía retrógrada, que define ubicación y longitud.
- Retención aguda con sonda imposible: cistostomía suprapúbica por punción.
- Seguimiento: derivar a urología para uretrotomía interna o uretroplastía.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 55

Paciente masculino de 30 años consulta por disminución del calibre miccional, asociada a disuria de esfuerzo de varios meses de evolución. Tiene antecedente de un trauma perineal hace 3 años. Al examen físico tiene genitales externos normales y su tacto rectal demuestra una próstata pequeña y blanda. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Cáncer de próstata
B) Uretritis
C) Hiperplasia prostática benigna
D) Estenosis uretral
E) Urolitiasis

Respuesta D. Un hombre joven con chorro débil progresivo y antecedente de trauma perineal (lesión de uretra bulbar) tiene una estenosis uretral hasta demostrar lo contrario. Se estudia con uroflujometría y uretrografía retrógrada. La HPB ocurre en mayores y con próstata aumentada de tamaño.

4.03.1.009 Fimosis, parafimosis

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: uro-16

QUÉ HAY QUE SABER

- Fimosis: imposibilidad de retraer el prepucio; es fisiológica en el lactante y preescolar y se resuelve espontáneamente en la mayoría; no se debe retraer a la fuerza.
- Patológica: anillo cicatricial blanquecino (liquen escleroso), balanitis o ITU recurrentes, o 'globo' prepucial con dificultad miccional.
- Tratamiento inicial: corticoide tópico (betametasona 0,05% 2 veces al día por 4–8 semanas) con retracción suave; circuncisión si fracasa o hay fimosis cicatricial o complicaciones.
- Parafimosis: prepucio retraído que no vuelve y forma anillo constrictor con edema del glande, típicamente tras sonda o examen; es urgencia: compresión del edema, analgesia y reducción manual.
- Seguimiento: control de respuesta al corticoide y derivar a cirugía/urología para circuncisión electiva cuando corresponda (incluida la parafimosis ya reducida).

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 62

Niño de 5 años con incapacidad de retraer el prepucio sobre el glande. Sin dolor ni infecciones previas. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Circuncisión electiva inmediata
B) Tranquilizar: fimosis fisiológica normal hasta los 6-7 años; observar
C) Corticoides tópicos en el prepucio
D) Derivar a urología
E) Dilatación manual bajo anestesia

Respuesta B. La fimosis fisiológica es normal en la infancia y se resuelve espontáneamente en la mayoría. Sin balanitis recurrente, ITU, cicatriz (fimosis patológica) ni globo prepucial con obstrucción, se observa. La retracción forzada está contraindicada porque produce fisuras y fimosis cicatricial. Si persiste o hay síntomas, los corticoides tópicos son la primera opción.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 114 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 3 años acude a control sano. Su madre refiere que tiene estrechez del prepucio y, al examen físico, se confirma que el prepucio es irreductible . ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Aplicar ungüento antibiótico
B) Realizar tracción manual forzada del prepucio
C) Realizar circuncisión
D) Aplicar ungüento de corticoide tópico
E) Controlar en un año

Respuesta D. Conducta / Tratamiento indicado: Aplicar ungüento de corticoide tópico (opción D). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

4.03.1.010 Hematuria

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 13.12 Cáncer de Vejiga: Hematuria Macroscópica Silente, Cistoscopía & RTUV · Tema 13.15 Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas

QUÉ HAY QUE SABER

- Hematuria microscópica: ≥3 GR por campo (400x) en 2 de 3 sedimentos; la tira reactiva da falsos positivos (mioglobina, hemoglobina) y debe confirmarse con sedimento.
- Glomerular: orina té/coca-cola, sin coágulos, GR dismórficos >80% o acantocitos >5%, cilindros hemáticos y proteinuria: derivar a nefrología.
- Urológica: roja, con coágulos (descartan origen glomerular), GR isomórficos y sin proteinuria; causas litiasis, cáncer, HPB, infección.
- Banderas rojas de cáncer urotelial: >50 años (o >35–40 con riesgo), tabaco >10 paquetes-año, aminas aromáticas, irradiación pélvica, hematuria macroscópica previa.

- Conducta inicial: urocultivo; si es urológica, derivar para uro-TAC con fase excretora y cistoscopía. Microhematuria aislada en niño: repetir el examen antes de estudiar.
- Seguimiento: derivar a urología o nefrología según el origen.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Hombre de 65 años, fumador de 30 cigarrillos diarios por 40 años. Hace 5 días tuvo orina francamente roja con coágulos alargados durante toda la micción, indolora, que cedió en 24 horas. Examen físico normal. Sedimento con hematuria sin leucocitos ni proteinuria. **¿Cuál es el examen que confirma el diagnóstico más probable?**

A) Antígeno prostático específico
B) Cistoscopía
C) Urocultivo y antibióticos empíricos
D) Radiografía simple de abdomen
E) Observación, porque cedió solo

Respuesta B. Hematuria macroscópica indolora con coágulos en un fumador adulto mayor es cáncer de vejiga hasta demostrar lo contrario. Que ceda solo no lo descarta. Se confirma con cistoscopía y resección transuretral.

Pregunta de práctica

Hombre de 62 años, jubilado de una fábrica de pinturas y fumador de 25 paquetes-año. Asintomático, con microhematuria en un control preventivo. Sedimento: 35 a 40 glóbulos rojos por campo, 95% isomórficos, sin acantocitos ni cilindros. Proteinuria negativa, urocultivo estéril, creatinina 0,8 mg/dL. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Derivar a nefrología para biopsia renal
B) Derivar a urología para uro-TAC y cistoscopía
C) Repetir el examen en un año
D) Indicar antibióticos empíricos
E) Solicitar C3, C4 y ANCA

Respuesta B. Es una microhematuria urológica (isomórfica, sin cilindros ni proteinuria) con riesgo oncológico alto: más de 50 años, tabaquismo y exposición laboral a aminas aromáticas. Se estudia con uro-TAC con fase excretora y cistoscopía.

4.03.1.011 Hidrocele

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 13.7 Patología Escrotal No Dolorosa: Varicocele, Hidrocele, Espermatocele & Quistes

QUÉ HAY QUE SABER

- Hidrocele: líquido entre las hojas de la túnica vaginal; masa escrotal indolora, lisa, que rodea al testículo (no se palpa aparte), transilumina y permite palpar el cordón por encima.
- En el lactante suele ser comunicante (persistencia del conducto peritoneovaginal) y se resuelve espontáneamente antes de 1–2 años; si varía de tamaño o persiste, cirugía.
- En el adulto siempre ecografía testicular: confirma y descarta hidrocele secundario a tumor o infección.
- Tratamiento: observar si es asintomático; hidrocelectomía si es grande o molesta. No puncionar (recidiva rápida e infección).
- Seguimiento: control clínico; masa que no transilumina o testículo no evaluable obliga a ecografía.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 45 años consulta por aumento de volumen del hemiescroto izquierdo, indoloro, de crecimiento lento en 1 año. Al examen se palpa una masa quística, lisa, que no permite palpar bien el testículo, transilumina y no se reduce. Se puede palpar el cordón espermático por encima de la masa. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Punción evacuadora repetida como tratamiento definitivo
B) Ecografía testicular para confirmar el diagnóstico y descartar una causa secundaria, como tumor o infección, y luego cirugía electiva si es sintomático
C) Herniorrafia inguinal urgente
D) Orquiectomía inguinal radical
E) Antibióticos por 14 días

Respuesta B. Una masa quística que transilumina, envuelve al testículo y permite palpar el cordón por encima es un hidrocele. En el adulto siempre se solicita ecografía, porque el testículo no se palpa bien y el hidrocele puede ser secundario a tumor o infección. Si molesta, se trata con hidrocelectomía; la punción tiene alta recidiva.

4.03.1.012 Hidronefrosis

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 13.2 Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía

QUÉ HAY QUE SABER

- Hidronefrosis: dilatación de la pelvis y cálices por obstrucción (litiasis, estenosis pieloureteral, tumor, HPB, compresión extrínseca) o reflujo; si es bilateral orienta a obstrucción infravesical.
- Sospechar ante dolor lumbar, masa en flanco, ITU recurrente o injuria renal aguda/postrenal; en la IRA el primer paso es descartar obstrucción con ecografía renal y vesical.
- Hidronefrosis sin dilatación ureteral sugiere estenosis pieloureteral; con dilatación ureteral, obstrucción distal o reflujo.
- Urgencia: hidronefrosis infectada (fiebre) o riñón único/anuria: descompresión urgente con catéter doble J o nefrostomía percutánea, además de antibióticos.
- Obstrucción baja con globo vesical: sonda Foley y vigilar diuresis postobstructiva (>1.000 mL evacuados: poliuria e hipokalemia).
- Seguimiento: derivar a urología; cintigrama MAG3/DTPA con diurético para obstrucción y función diferencial.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 74

Paciente de 18 años consulta por dolor lumbar izquierdo de larga evolución. Al examen físico tiene una masa en el flanco izquierdo. La ecografía abdominal muestra hidronefrosis izquierda con adelgazamiento de la corteza renal, sin dilatación ureteral. Su creatinina plasmática es 0,9 mg/dL y su sedimento de orina es normal. La cintigrafía renal muestra función diferencial de 90% a derecha y 10% a izquierda. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar pieloplastía izquierda
B) Realizar nefrostomía percutánea
C) Realizar nefrectomía izquierda
D) Instalar sonda Foley
E) Solicitar pieloTAC

Respuesta C. Hidronefrosis sin dilatación ureteral indica estenosis pieloureteral. Con corteza adelgazada y función diferencial de 10% o menos en la cintigrafía, el riñón se considera no recuperable y sintomático: se indica nefrectomía. Si la función estuviera conservada, la conducta sería pieloplastía. La nefrostomía es solo una medida transitoria de drenaje.

4.03.1.013 Hiperplasia prostática benigna

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 13.3 Hiperplasia Prostática Benigna (HPB): IPSS, Tacto Rectal, Tamsulosina/Finasteride & RTUP

QUÉ HAY QUE SABER

- HPB: nace en la zona de transición; síntomas de vaciado (chorro débil, latencia, goteo) y de llenado (nicturia, polaquiuria, urgencia). El tamaño no se correlaciona con los síntomas.
- Evaluación: IPSS (0–7 leve, 8–19 moderado, 20–35 severo), tacto rectal (próstata aumentada, lisa, elástica, indolora; nódulo pétreo sugiere cáncer), sedimento, creatinina y APE.
- Tratamiento: leve, observación y hábitos; moderado-severo, tamsulosina 0,4 mg/día (efecto en 48–72 h, no cambia volumen ni APE; eyaculación retrógrada, hipotensión ortostática, iris flácido en cirugía de cataratas).
- Próstata >40 cc: agregar finasteride 5 mg/día o dutasteride (reducen volumen 20–25% en 3–6 meses y el APE a la mitad: multiplicar por 2).
- Indicaciones absolutas de cirugía: retención aguda refractaria o repetida, ITU recurrente, litiasis vesical, hematuria prostática recurrente, divertículos o daño renal; RTUP si <80 cc. Cirugía de HPB sintomática tiene garantía GES.
- Seguimiento: control de síntomas con IPSS, residuo postmiccional y función renal; evitar anticolinérgicos y antihistamínicos que precipitan retención.

PREGUNTAS (5)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 8

Un paciente de 50 años, diabético en tratamiento con metformina, consulta por poliaquiuria, nicturia, latencia y debilidad del chorro miccional desde hace meses, no asociado a otros síntomas. Su tacto rectal muestra próstata aumentada de tamaño de consistencia gomosa. Con respecto a este caso, **¿Cuál de las siguientes es una indicación absoluta para resolución quirúrgica en esta patología?**

A) Hematuria en una ocasión
B) Retención aguda de orina
C) Residuo postmiccional de 150 ml
D) Prostata mayor a 40 cc
E) Antígeno prostático de 5 ng/ml

Respuesta B. Es una HPB. La retención urinaria aguda es indicación absoluta de cirugía. Hematuria en una ocasión y residuo de 150 ml son indicaciones relativas. El APE elevado solo es indicación de biopsia.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 80

Un paciente de 70 años, con antecedente de hiperplasia prostática benigna, consulta por escapes de grandes cantidades de orina, asociada a deseos intensos de ir al baño. Se solicita una ecografía vesicoprostática que visualiza adenoma prostático de 50 cc de volumen, vejiga urinaria con paredes engrosadas y residuo postmiccional significativo **¿Cuál es la indicación más adecuada?**

A) Imipramina oral
B) Tamsulosina oral
C) Amitriptilina oral
D) Tolterodina oral
E) Cloruro de trospio

Respuesta B. HPB con complicaciones y escapes de orina por rebalse. El alfabloqueante es el tratamiento de primera línea para la HPB con síntomas obstructivos y residuo postmiccional significativo.

Pregunta de práctica

Hombre de 71 años en tratamiento con Finasteride 5 mg/día desde hace 1 año por HPB. En su control anual asintomático, el laboratorio informa un APE total sérico de 2.8 ng/mL. El tacto rectal no revela nódulos. **¿Cómo debe interpretarse el valor real de su APE sérico para fines de screening de cáncer de próstata?**

A) El valor real es 2.8 ng/mL y se considera normal para su edad
B) El valor real es 5.6 ng/mL y se encuentra en zona de sospecha oncológica
C) El valor real es 1.4 ng/mL debido a la sobrestimación por tiazidas
D) El valor del APE es inválido y debe suspenderse el finasteride por 1 mes para repetir
E) El finasteride no altera el valor plasmático del APE

Respuesta B. Los inhibidores de la 5-alfa reductasa reducen el APE en 50% a partir de los 6 meses de uso continuo. Para interpretarlo, se duplica el valor informado: 2,8 por 2 son 5,6 ng/mL, que cae en la zona de sospecha y exige estudio.

Pregunta de práctica

Hombre de 68 años con 2 años de nicturia 4 a 5 veces, chorro débil y entrecortado y sensación de vaciamiento incompleto. IPSS 22. Sin globo vesical. Tacto rectal: próstata de 55 cc, lisa, de bordes netos, fibroelástica, sin nódulos. APE 2,4 ng/mL, creatinina 0,9 mg/dL y sedimento normal. Residuo postmiccional de 130 mL. **¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?**

A) Tamsulosina más finasteride
B) Resección transuretral urgente
C) Ciprofloxacino por 2 semanas
D) Biopsia prostática
E) Oxibutinina

Respuesta A. HPB con síntomas severos y próstata de más de 40 cc, con tacto rectal y APE benignos y sin complicaciones orgánicas. Se parte con tratamiento médico: un alfa uno bloqueante, que actúa rápido, junto a un inhibidor de la 5-alfa reductasa, que frena el crecimiento. La cirugía no está indicada todavía, ni la biopsia, porque el APE y el tacto son normales.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 104 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 65 años, con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento con enalapril y diabetes mellitus en tratamiento con metformina y glibenclamida, presenta desde hace 3 meses y en forma progresiva, poliaquiuria y nicturia, asociado a latencia, chorro miccional doble y débil. Al examen físico se palpa próstata aumentada de tamaño de consistencia gomosa. Se solicita antígeno prostático que resulta en 3,5ng/ml. La conducta más adecuada en este caso es:

A) Realizar prostatectomía vía resección transuretral
B) Realizar prostatectomía por vía retropúbica
C) Indicar alfa agonista
D) Indicar inhibidor de la 5 alfa reductasa
E) Indicar análogos de la hormona liberadora de gonadotropinas

Respuesta A. El paciente tiene síntomas obstructivos e irritativos de hiperplasia prostática benigna con antígeno prostático normal. El tratamiento inicial sería farmacológico con alfabloqueadores, pero entre las alternativas la única conducta aceptable es la resección transuretral, ya que el llamado alfa agonista no corresponde al fármaco correcto. Los inhibidores de la 5 alfa reductasa tardan meses en actuar

4.03.1.014 Incontinencia urinaria

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 13.4 Incontinencia Urinaria en el Adulto: Esfuerzo vs Urgencia vs Rebose & Vejiga Neurogénica

QUÉ HAY QUE SABER

- Incontinencia de esfuerzo: escape en pequeños chorros con tos, risa o salto, sin deseo previo (falla del cierre, multíparas). Urgencia: deseo imperioso que no da tiempo, con nicturia (detrusor hiperactivo).
- Rebalse: goteo continuo sin deseo, con residuo postmiccional >200 mL (HPB avanzada, estenosis o vejiga neurogénica diabética). Siempre medir residuo y pedir sedimento y urocultivo.
- Esfuerzo: ejercicios de Kegel supervisados por kinesiólogo 8–12 semanas; si fracasa, cinta suburetral TOT/TVT (éxito >85%). Los anticolinérgicos no sirven.
- Urgencia: reentrenamiento vesical, evitar cafeína y tabaco; oxibutinina 5 mg c/8–12 h, tolterodina (menos boca seca) o mirabegrón 50 mg/día (preferido en ancianos).
- Rebalse: aliviar la obstrucción o cateterismo intermitente limpio; nunca anticolinérgicos. Mixta: tratar la que predomina.
- Seguimiento: derivar a urología/uroginecología si es mixta refractaria, hay prolapso, residuo alto o se plantea cirugía (urodinamia previa).

PREGUNTAS (9)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 101

Mujer de 56 años con escapes de orina en grandes cantidades, precedidos por deseos incontrolables de orinar. También presenta escapes en la noche. Al examen no hay pérdida con la maniobra de Valsalva. Urocultivo negativo y sedimento normal. La ecografía muestra vejiga de paredes delgadas, sin cálculos ni residuo postmiccional. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A) Iniciar tamsulosina
B) Iniciar oxibutinina
C) Realizar cistoscopía
D) Realizar suspensión uretral con cinta transvaginal
E) Indicar ejercicios de kinesioterapia pélvica

Respuesta B. El escape precedido por deseo urgente, sin relación con el esfuerzo, y con Valsalva negativo, es incontinencia de urgencia. El tratamiento inicial es conductual y farmacológico con anticolinérgicos como la oxibutinina; la cirugía no tiene rol aquí.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 121

Una paciente de 60 años presenta incontinencia urinaria de 2 años de evolución, caracterizada por escapes de orina precedidos por urgencia miccional incontrolable, por lo que utiliza 3 a 5 protectores al día. Su examen físico es normal, al igual que su exploración ginecológica. Se solicita una ecografía abdominal que muestra vía urinaria de calibre normal y vejiga urinaria sin lesiones, con residuo postmiccional de 30 cc. **¿Qué fármaco es más adecuado como tratamiento de primera línea?**

A) Bloqueadores alfa adrenérgicos
B) Bloqueadores beta adrenérgicos
C) Agonistas adrenérgicos
D) Anticolinérgicos muscarínicos
E) Estrógenos

Respuesta D. Urgencia miccional con residuo normal: incontinencia de urgencia. Tras las medidas conductuales y el entrenamiento vesical, el fármaco clásico son los antimuscarínicos (oxibutinina, tolterodina). El mirabegrón (agonista beta-3) se prefiere si hay deterioro cognitivo o riesgo de delirium.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 76

Una mujer de 65 años de edad, multípara de 4, con todos los partos por vía vaginal, con menopausia a 50 años, sin terapia de reemplazo hormonal, presenta escape de pequeñas cantidades de orinal, al realizar esfuerzos, así como al toser o reírse, lo que la obliga a usar protectores. No tiene urgencia miccional. Su examen físico no aporta mayor información, pero es posible visualizar leve escape de orina, al toser. **¿Cuál es el tratamiento de primera línea para esta paciente?**

A) Cirugía (TVT)
B) Anticolinérgicos
C) Alfa adrenérgicos
D) Kinesioterapia del piso pélvico
E) Antibióticos, como profilaxis de ITU

Respuesta D. Pérdidas pequeñas con tos, risa y esfuerzos, sin urgencia, en multípara posmenopáusica: incontinencia de esfuerzo. Primera línea: kinesioterapia del piso pélvico (Kegel); la cirugía TVT o TOT queda si fracasa.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 48

Una paciente de 69 años diabética, mal controlada, presenta escapes de orina. Además ha presentado algunas infecciones urinarias. Su urocultivo actual está negativo, pero consulta por la incontinencia urinaria. Se realiza una ecografía que muestra una vejiga de paredes lisas, con volumen urinario de 930cc y residuo postmiccional de 750cc. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Resolver quirúrgicamente
B) Instalar una sonda Foley
C) Realizar cateterismo intermitente
D) Indicar anticolinérgicos
E) Indicar colinérgicos

Respuesta C. Residuo postmiccional muy elevado en una diabética mal controlada: incontinencia por rebose por vejiga acontráctil (neuropatía diabética). Se trata con cateterismo limpio intermitente; los anticolinérgicos están contraindicados.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 79

Una mujer de 73 años, presenta escapes de orina, precedidos por grandes e incontrolables deseos de orinar. Además, ha tenido escapes de orina en la noche. Al examen físico, no hay mayores alteraciones. Se solicita una ecografía vesical, que visualiza una vejiga urinaria de paredes delgadas, sin litiasis y sin residuo postmiccional significativo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar cistoscopía
B) Realizar suspensión uretral con cinta transvaginal
C) Iniciar oxibutinina
D) Indicar ejercicios de piso pélvico
E) Realizar cirugía abierta de piso pélvico

Respuesta C. Escapes precedidos por deseo imperioso, con residuo normal: incontinencia de urgencia. Se trata con anticolinérgicos, como la oxibutinina.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 49

Una paciente de 81 años, multípara de 3, histerectomizada, inicia escapes de orina de esfuerzos hace 5 años y además, desde hace 2 años tiene escapes de urgencia. No tiene antecedente de infecciones urinarias, ni hematuria. Al examen físico se aprecia un grado leve de prolapso genital. Se realiza sedimento de orina con 4-5 leucocitos por campo y 2-3 hematíes por campo, sin bacterias y se realiza un urocultivo, que resulta negativo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar tratamiento quirúrgico del prolapso
B) Indicar ejercicios de fortalecimiento del piso pélvico
C) Iniciar anticolinérgicos
D) Iniciar alfabloqueadores adrenérgicos
E) Solicitar ecografía abdomino-pélvica

Respuesta B. Es una incontinencia mixta en que predomina el esfuerzo, y el sedimento y el urocultivo descartan infección. Se parte con ejercicios del suelo pélvico.

Pregunta de práctica

Mujer de 54 años, con tres partos vaginales, consulta por escapes de orina de un año, en chorros pequeños al toser, reír o saltar. No tiene urgencia ni nicturia. Hay un cistocele grado I y sale orina por el meato al toser. Residuo postmiccional por ecografía: 15 mL. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Oxibutinina 5 mg cada 8 horas
B) Ejercicios de suelo pélvico con kinesiólogo
C) Cinta transobturatriz de inmediato
D) Cateterismo intermitente limpio
E) Mirabegrón 50 mg al día

Respuesta B. Es una incontinencia de esfuerzo no complicada, con residuo normal. La primera línea son los ejercicios de Kegel supervisados por kinesiólogo durante 8 a 12 semanas. La cinta suburetral queda para el fracaso o el escape severo. Los anticolinérgicos y el mirabegrón son para urgencia, y el cateterismo para rebalse.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 71 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 37 años presenta escapes de orina, en grandes cantidades, precedidos por deseos incontrolables de orinar. Su examen físico no aporta mayor información. Su urocultivo es negativo y su desimento de orina no presenta alteraciones. Se solicita una cistomanometría que muestra contracciones no inhibidas del detrusor, que aparecen entre los 80 y 100 cc de llenado vesical. El tratamiento inicial más adecuado es:

A) Anticolinérgicos
B) Bloqueadores alfa 1 adrenérgicos
C) Cirugía
D) Kinesioterapia pélvica
E) Reducación vesical

Respuesta A. Es una pregunta muy discutible, ya que, si bien está claro que tiene una incontinencia urinaria de urgencia, tanto los anticolinérgicos, como la terapia conductual (reeducación vesical sería lo más similar a ello) son tratamientos adecuados. Como se pregunta el tratamiento inicial, yo marqué la E, siguiendo las recomendaciones norteamericanas. Pero, la verdad, es que aquello es discutido por las a

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 112 · texto original del banco, sin revisar

Paciente adulta mayor con cuadro clásico de incontinencia urinaria de esfuerzo, conducta: a. Kinesioterapia pélvica

A) Amoxicilina
B) Ibuprofeno
C) Paracetamol
D) Omeprazol
E) Metformina

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Amoxicilina (opción A). La fístula vesico-vaginal, típicamente postquirúrgica tras histerectomía o cesárea, produce goteo urinario continuo; se diagnostica con uretrositografía y el tratamiento es quirúrgico De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

4.03.1.015 Infección urinaria alta y baja

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 5.4 Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto

QUÉ HAY QUE SABER

- Cistitis: disuria, polaquiuria y urgencia, nunca fiebre. Pielonefritis: fiebre >38,5 °C con calofríos, dolor lumbar y puñopercusión positiva; puede faltar la clínica baja en ancianos.
- Cistitis no complicada en mujer joven: no requiere urocultivo; nitrofurantoína 100 mg c/12 h por 5 días (alternativas fosfomicina 3 g dosis única o cefalosporina oral).
- Pielonefritis: urocultivo con antibiograma antes del antibiótico; ambulatoria: ciprofloxacino 500 mg c/12 h por 7 días o cefalosporina oral 10–14 días. Nitrofurantoína y fosfomicina no sirven en pielonefritis.
- Hospitalizar si hay embarazo, intolerancia oral, sepsis, obstrucción o falla renal, o inmunosupresión: ceftriaxona 1–2 g/día EV (BLEE o shock: ertapenem/meropenem). Embarazo: ceftriaxona, nunca quinolonas.
- Bacteriuria asintomática: tratar solo en embarazadas y antes de procedimientos urológicos con sangrado de mucosa.
- Seguimiento: control a las 48–72 h; sin respuesta con germen sensible, TAC o ecografía para buscar absceso u obstrucción. Cistitis recurrente poscoital: orinar tras el coito y profilaxis poscoital.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 6

Se atiende a una paciente de 26 años con antecedente de infecciones del tracto urinario a repetición desde hace 4 años, coincidiendo con el inicio de sus relaciones sexuales. Ha presentado urocultivos positivos para Escherichia coli con una frecuencia de 5 a 6 episodios por año. Su examen físico actual es normal, el urocultivo es negativo y el panel de PCR para infecciones de transmisión sexual también resulta negativo. Una ecografía renal y vesical previa resultó normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar cistoscopía
B) Solicitar PCR para Mycobacterium tuberculosis en orina
C) Iniciar flavoxato vía oral
D) Profilaxis antibiótica poscoital
E) Indicar uso de preservativo durante las relaciones sexuales

Respuesta D. Cistitis recurrente (3 o más al año) claramente asociada al coito, con ecografía normal, se maneja con profilaxis antibiótica poscoital en dosis única (nitrofurantoína o cotrimoxazol). En mujeres jóvenes sin factores de complicación no se requieren cistoscopía ni más estudio. El flavoxato es solo un antiespasmódico.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 108 · texto original del banco, sin revisar

Mujer de 25 años con infecciones urinarias recurrentes (>3 episodios/año) claramente asociadas a relaciones sexuales. ¿Cuál es la profilaxis más adecuada?

A) Nitrofurantoína 50 mg o cotrimoxazol post coito
B) Ciprofloxacino 500 mg diario indefinido
C) Amoxicilina 500 mg diario
D) Solo higiene y micción postcoital
E) Vacuna anti-E. coli

Respuesta A. ITU recurrente postcoital: profilaxis antibiótica postcoito con una dosis única de nitrofurantoína 50-100 mg o cotrimoxazol 480 mg reduce recurrencias en >95% de los casos.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 93 · texto original del banco, sin revisar

Mujer de 55 años con ITU a repetición (>3 episodios/año) que recibe profilaxis con nitrofurantoína. Tiene antecedente de fibrosis pulmonar idiopática. ¿Cuál es el cambio terapéutico más adecuado?

A) Amoxicilina profiláctica
B) Cefalexina profiláctica
C) Cotrimoxazol profiláctico
D) Suspender profilaxis y observar
E) Mantener nitrofurantoína sin cambios

Respuesta C. Nitrofurantoína está contraindicada en fibrosis pulmonar (puede agravar la enfermedad pulmonar y causa toxicidad pulmonar crónica). Cambio a cotrimoxazol (trimetoprim-sulfametoxazol) profiláctico postcoital o cíclico es la alternativa de elección para ITU recurrente.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 4 · texto original del banco, sin revisar

Pregunta 4 Sin contestar Puntúa como 1,00 Marcar pregunta Un paciente se realiza una cirugía transuretral hace 7 días. Evoluciona con disuria dolorosa, asociada a malestar general y fiebre hasta 38,7 grados Celsius. Se realiza un sedimento de orina con leucocituria de 50 por campo y abundantes bacterias, y un urocultivo, que resulta positivo para Pseudomona aureginosa y el antibiograma está pendiente. El tratamiento de elección es:

A) Amoxicilina-clavulánico
B) Nitrofurantoína
C) Cotrimoxazol
D) Imipenemen
E) Ceftriaxona

Respuesta D. Conducta / Tratamiento indicado: Imipenemen (opción D). De las opciones que aparecían, el imipenem era el único con cobertura para Pseudomona.. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

4.03.1.016 Infección urinaria específica

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.3 Tuberculosis: Formas Extrapulmonares, Diagnóstico y Manejo MDR

QUÉ HAY QUE SABER

- Tuberculosis urogenital: forma extrapulmonar por siembra hematógena; síntomas irritativos persistentes, hematuria y piuria estéril (leucocituria con urocultivo convencional negativo) en orina ácida.
- Sospechar ante 'ITU' que no responde a antibióticos, antecedente de TBC, inmunosupresión o epididimitis crónica con fístula escrotal.
- Confirmación: baciloscopía y cultivo de Koch en 3 a 6 muestras seriadas de primera orina matinal, o PCR (GeneXpert); uro-TAC muestra estenosis ureterales, calcificaciones y vejiga retraída.
- Tratamiento inicial: esquema nacional 2RHZE/4RH directamente observado, notificación y estudio de contactos; ante masa de pelvis renal o duda diagnóstica, derivar.
- Seguimiento: derivar a urología por secuelas (estenosis ureteral, hidronefrosis, vejiga contraída) que requieren manejo especialista.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 45 años, con antecedente de tuberculosis pulmonar tratada hace 10 años, consulta por disuria, polaquiuria y hematuria intermitente de 4 meses. Ha recibido 2 cursos de antibióticos sin mejoría. El sedimento urinario muestra leucocituria abundante con orina ácida, y los urocultivos convencionales han sido repetidamente negativos. **¿Cuál es el estudio más adecuado para confirmar el diagnóstico?**

A) Urocultivo con antibiograma nuevamente
B) Citología urinaria
C) Cultivo de orina para Mycobacterium tuberculosis (Koch) en muestras seriadas de primera orina de la mañana
D) PCR para Chlamydia trachomatis en orina
E) Ecografía testicular

Respuesta C. La piuria estéril (leucocituria con urocultivo convencional negativo) con orina ácida, hematuria y síntomas irritativos persistentes sugiere tuberculosis urogenital, más aún con antecedente de TBC. Se confirma con baciloscopía y cultivo de Koch en al menos 3 a 6 muestras seriadas de la primera orina matinal (o PCR para M. tuberculosis), y se estudia con uroTAC.

4.03.1.017 Infertilidad masculina

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 20.7 Infertilidad Conyugal: Estudio Básico Inicial en Cuatro Pilares y Técnicas de Reproducción Asistida

QUÉ HAY QUE SABER

- Infertilidad: falta de embarazo tras 12 meses de relaciones sin protección (6 meses si la mujer tiene ≥35 años); el factor masculino participa en alrededor de un tercio de los casos y se estudia siempre en pareja.
- Primer examen: espermiograma con 3–5 días de abstinencia; si sale alterado, se repite a las 4–12 semanas antes de concluir.

- Buscar causas: varicocele (la causa tratable más frecuente), criptorquidia, orquitis urliana, ITS, fármacos/anabólicos, tabaco y calor; examen testicular (volumen y consistencia).
- Azoospermia con testículos pequeños y firmes, ginecomastia y LH/FSH altas: hipogonadismo primario, probable Klinefelter (cariograma); LH/FSH bajas: hipogonadismo central.
- Medidas iniciales: suspender anabólicos, tabaco y alcohol, control de peso; derivar a urología/andrología con espermiograma alterado confirmado.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 75

Hombre de 33 años, lleva 18 meses intentando concebir un hijo con su pareja. Ella tiene reglas regulares. Él tiene examen físico y genital normal. **¿Con qué examen debemos iniciar el estudio en este paciente?**

A) Hormona luteinizante
B) Hormona folículo estimulante
C) Espermiograma
D) Cultivo de líquido seminal
E) Ecografía testicular

Respuesta C. El primer examen del estudio de infertilidad masculina es siempre el espermiograma, sin importar que el examen físico sea normal. Las hormonas o la imagen se piden solo si el espermiograma resulta alterado.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 43 · texto original del banco, sin revisar

Una pareja consulta por infertilidad de 2 años de evolución. Ella no tiene anteceden- tes de importancia y tanto su examen físico, como exploración ginecológica son norma- les. Él realiza ciclismo de montaña y en su examen físico se constatan testículos de ta- maño pequeño, sin otras alteraciones. ¿Cuál es el primer examen para evaluarlo?

A) Espermiograma
B) Ecografía testicular
C) Niveles plasmáticos de LH, FSH y testosterona
D) Niveles plasmáticos de TSH, prolactia
E) Biopsia testicular

Respuesta A. El espermiograma es el examen de elección para el inicio del estudio de la infertili- dad masculina.

4.03.1.018 Lesiones quísticas del riñón

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 13.14 Quistes Renales Simples (Bosniak) & Riñón Poliquístico Autosómico Dominante

QUÉ HAY QUE SABER

- Quiste renal simple: hallazgo frecuente y benigno (>50% en mayores de 50 años); criterios ecográficos: anecogénico, pared fina, redondo con borde nítido y refuerzo acústico posterior.
- Si cumple los criterios (Bosniak I): tranquilizar y dar de alta sin seguimiento. Si tiene tabiques, calcificaciones o ecos: TAC con contraste y clasificar con Bosniak.
- Bosniak II benigno; IIF (~5% malignidad) control con TAC a los 6 y 12 meses; III (50–60%) y IV (85–100%) son quirúrgicos: derivar.
- Poliquistosis renal autosómica dominante (PKD1 85%, PKD2): riñones grandes bilaterales, HTA precoz, hematuria, quistes hepáticos e historia familiar; progresa a insuficiencia renal.
- Manejo PQRAD: presión <130/80 con IECA/ARA-II; cefalea súbita 'la peor de su vida' sugiere rotura de aneurisma de Berry (8–10%): TAC de cerebro urgente; angio-RM si hay historia familiar.
- Seguimiento: quiste simple sin control; PQRAD con control de PA, función renal y derivación a nefrología.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 54 años asintomática, ecografía de chequeo: en el polo superior del riñón izquierdo hay una lesión anecogénica de 3,8 cm, redondeada, de paredes delgadas e imperceptibles, con refuerzo acústico posterior nítido y sin tabiques ni calcificaciones. Examen físico y función renal normales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Tranquilizar a la paciente y darle el alta sin seguimiento
B) TAC de abdomen y pelvis con contraste para descartar malignidad
C) Punción percutánea aspirativa para citología
D) Repetir la ecografía cada 6 meses por 3 años
E) Derivar para quistectomía laparoscópica electiva

Respuesta A. Cumple todos los criterios de quiste simple benigno (Bosniak I): anecogénico, pared imperceptible, refuerzo posterior, sin tabiques. No requiere TAC, punción ni controles seriados.

4.03.1.019 Malformaciones congénitas nefrourológicas

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 18.13 Infección del Tracto Urinario (ITU) en Pediatría: ITU Febril, Estudio por Imágenes & Profilaxis

QUÉ HAY QUE SABER

- Malformaciones nefrourológicas (CAKUT): principal causa de ERC en niños; incluyen hidronefrosis por estenosis pieloureteral, reflujo vesicoureteral, megauréter, valvas uretrales posteriores, riñón multiquístico, agenesia y ectopia.
- Sospecha: pielectasia en ecografía prenatal, ITU febril (sobre todo en lactantes), masa abdominal, chorro débil o retraso miccional en recién nacido varón.
- Valvas uretrales posteriores: RN varón con hidroureteronefrosis bilateral y vejiga de lucha; sonda vesical precoz y derivación urgente (resección endoscópica).
- Estudio inicial: ecografía renal y vesical en todo niño con primera ITU febril o pielectasia prenatal; uretrocistografía miccional si la eco es anormal o la ITU es atípica/recurrente.
- Manejo inicial: tratar la ITU y considerar profilaxis antibiótica en dilataciones importantes o reflujo de alto grado.
- Seguimiento: derivar a nefrología o urología infantil; cintigrama DMSA para cicatrices y MAG3 para obstrucción.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 20

Un recién nacido de sexo masculino, con antecedente de pielectasia bilateral diagnosticada por ecografía obstétrica, presenta retraso en la eliminación de orina. La ecografía abdominal al tercer día de vida muestra hidroureteronefrosis bilateral asociada a una vejiga de paredes engrosadas. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Valvas uretrales posteriores
B) Síndrome de Prune Belly
C) Reflujo vésico-ureteral
D) Vejiga neurogénica
E) Megauréter congénito

Respuesta A. Hidroureteronefrosis bilateral con vejiga de paredes engrosadas (de lucha) en un recién nacido varón con micción retrasada es una obstrucción infravesical: valvas uretrales posteriores. Se confirma con uretrocistografía miccional (uretra posterior dilatada) y se maneja con sonda vesical y resección endoscópica. El megauréter suele ser unilateral y sin vejiga de lucha.

4.03.1.020 Quistes del epidídimo

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 13.7 Patología Escrotal No Dolorosa: Varicocele, Hidrocele, Espermatocele & Quistes

QUÉ HAY QUE SABER

- Quiste de epidídimo/espermatocele: masa lisa, indolora, en la cabeza del epidídimo (polo superior), separada y extratesticular, que transilumina; el espermatocele contiene líquido lechoso con espermatozoides.
- Confirmación: ecografía testicular muestra lesión líquida bien delimitada extratesticular; toda masa intratesticular sólida es cáncer hasta demostrar lo contrario.
- Tratamiento: observación si es asintomático (son benignos); resección quirúrgica (espermatocelectomía) solo si duele o es grande.
- No puncionar ni hacer orquiectomía por un quiste de epidídimo.

- Seguimiento: control clínico o ecográfico; consultar si crece o aparece dolor.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 124

Un paciente de 18 años, asintomático, se palpa un tumor intraescrotal derecho, por lo que consulta. Al examen físico se palpa una tumoración extratesticular de 1,5 cm de diámetro, de consistencia elástica, indolora a la palpación. Se solicita ecografía escrotal que muestra parénquima testicular de aspecto normal, sin lesiones y se visualiza una lesión hipoecogénica de paredes finas, de 1,5 cm de diámetro, en relación con la cabeza del epidídimo derecho. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar orquiectomía radical
B) Realizar resección quirúrgica de la lesión del epidídimo
C) Realizar punción de la lesión
D) Indicar autoexamen testicular frecuente
E) Controlar ecográficamente en un año

Respuesta E. Parece un quiste del epidídimo. Suele observarse. El autoexamen testicular no cuenta con evidencia y la mayoría no lo recomienda.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 82 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 21 años, sin antecedentes, mientras jugaba futbol sufre golpe en zona testicular tras lo cual se palpa una masa. Al examen físico se palpa masa en polo superior blanda. Se solicita ecografía escrotal que muestra lesión quística en epidídimo de 3 cm de díametro, sin otros hallazgos. La conducta más adecuada en este caso es:

A) Orquiectomía por vía inguinal
B) Punción y aspiración del quiste
C) Orquiectomía por vía escrotal
D) Observación
E) Indicar inhibidores de la 5 alfa reductasa

Respuesta D. Conducta / Tratamiento indicado: Observación (opción D). Es un quiste del epidídimo. Se observan.. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

4.03.1.021 Reflujo vésico ureteral

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 18.13 Infección del Tracto Urinario (ITU) en Pediatría: ITU Febril, Estudio por Imágenes & Profilaxis

QUÉ HAY QUE SABER

- Reflujo vesicoureteral: paso retrógrado de orina de la vejiga al uréter; es la malformación más asociada a ITU febril en niños y causa cicatrices renales (nefropatía por reflujo).
- Sospecha: ITU febril recurrente, ecografía con dilatación pielocalicial o ureteral, o hidronefrosis prenatal; hermanos de pacientes con reflujo.
- Diagnóstico específico: uretrocistografía miccional, fuera de la fase aguda, que lo clasifica en grados I a V; se pide si la ecografía está alterada o la ITU es atípica/recurrente.
- Daño parenquimatoso: cintigrama DMSA 4–6 meses después de la pielonefritis para detectar cicatrices.
- Manejo inicial: tratar cada ITU con urocultivo por sondeo, profilaxis antibiótica (nitrofurantoína o cefadroxilo en dosis baja nocturna) en reflujo de alto grado o ITU recurrente; manejo de disfunción vesical e intestinal.
- Seguimiento: controles de urocultivo ante fiebre, PA y crecimiento renal; derivar a nefrología/urología infantil (corrección endoscópica o quirúrgica si hay ITU de brecha o daño progresivo).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Lactante de 8 meses cursa su segundo episodio de pielonefritis aguda por E. coli. La ecografía renal muestra dilatación pielocalicial bilateral leve. La uretrocistografía miccional muestra reflujo vésico-ureteral grado IV bilateral. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Profilaxis antibiótica continua y derivación a nefrología o urología infantil, con cintigrama DMSA para evaluar cicatrices
B) Cirugía de reimplante ureteral inmediata
C) Alta sin seguimiento, ya que el reflujo se resuelve siempre espontáneamente
D) Repetir la uretrocistografía en 1 semana
E) Tratamiento antibiótico solo durante los episodios febriles

Respuesta A. El RVU de alto grado (IV a V) con ITU febril recurrente en un lactante tiene alto riesgo de cicatrices renales. Se indica profilaxis antibiótica (nitrofurantoína o cefadroxilo), DMSA diferido para evaluar daño parenquimatoso y manejo por especialista; la corrección endoscópica o quirúrgica se reserva para ITU de brecha o daño progresivo.

4.03.1.022 Tumor renal

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 13.11 Cáncer Renal: Carcinoma de Células Claras, Tríada Clásica, TAC y Nefrectomía

QUÉ HAY QUE SABER

- Carcinoma de células renales (células claras ~80%): varón de 50–70 años, tabaco, obesidad, HTA; Von Hippel-Lindau (gen VHL).
- Hoy más del 65% es incidentaloma en ecografía o TAC; la tríada de Guyon (dolor en flanco, hematuria, masa palpable) indica enfermedad avanzada.
- Paraneoplásicos: hipercalcemia por PTHrP (medir PTH), policitemia por eritropoyetina, HTA por renina y síndrome de Stauffer (colestasis sin metástasis hepática).
- Masa renal sólida: TAC trifásico con contraste; realce >15–20 UH se presume cáncer y se opera sin biopsia de rutina. Varicocele derecho o que no colapsa en decúbito obliga a buscar tumor renal.
- Tratamiento (especialista): nefrectomía parcial en T1 (≤7 cm), radical en tumores grandes o centrales; avanzado con antiangiogénicos/inmunoterapia (es resistente a quimio y radioterapia).
- En niños, masa en flanco con hematuria sugiere tumor de Wilms: no palpar repetidamente y derivar. Seguimiento: derivar a urología.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 46

Un paciente de presenta dolor abdominal en el flanco izquierdo, por lo que se realiza una ecografía abdominal, que muestra un tumor renal sólido, de 2,5 cm de diámetro, en el polo superior del riñón derecho. Se solicita un TAC, que confirma el tumor renal de aspecto sólido y que capta contraste. ¿Cuál es la conducta más adecuada? **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Nefrectomía radical
B) Nefrectomía parcial
C) Nefroureterectomía
D) Iniciar inhibidores de la tirosinasa
E) Realizar seguimiento ecográfico

Respuesta B. Todo tumor renal sólido que capta contraste se presume cáncer renal. Si es pequeño, se hace nefrectomía parcial; la radical es para los grandes. La nefroureterectomía es para tumores de la pelvis renal.

Pregunta de práctica

Hombre de 56 años, fumador, hipertenso. Una ecografía pedida por dispepsia muestra una masa sólida de 3,5 cm en la corteza del polo superior del riñón izquierdo. Está asintomático, con creatinina normal y orina normal. El TAC trifásico muestra realce marcado, sin invasión de la vena renal ni adenopatías. **¿Cuál es la conducta de elección?**

A) Biopsia percutánea de la masa
B) Nefrectomía parcial
C) Nefrectomía radical con linfadenectomía
D) Sunitinib
E) Controles ecográficos cada 6 meses

Respuesta B. Masa sólida con realce franco, T1a, periférica y sin metástasis: carcinoma de células renales. La conducta curativa es la nefrectomía parcial, que preserva función renal. No se biopsia de rutina.

4.03.1.023 Tumor suprarrenal

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 7.15 Feocromocitoma y Paragangliomas: Bloqueo Alfa Obligatorio

QUÉ HAY QUE SABER

- Feocromocitoma: tumor de células cromafines; crisis paroxísticas de cefalea, sudoración profusa y palpitaciones con HTA (tríada con especificidad >90%); hasta 35–40% hereditario (NEM 2, VHL, NF1, SDH).
- Confirmar primero con bioquímica: metanefrinas libres plasmáticas o fraccionadas en orina de 24 h; si son normales prácticamente se descarta. La imagen (TC o RM) va después.
- Incidentaloma suprarrenal: todo requiere estudio funcional con supresión con 1 mg de dexametasona (Cushing subclínico) y metanefrinas; aldosterona/renina si hay HTA o hipokalemia. <10 UH sugiere adenoma.
- Sospechar malignidad si >4 cm, heterogéneo, >10 UH con lavado lento o crecimiento; no biopsiar (peligroso si es feocromocitoma).
- Tratamiento inicial del feocromocitoma: bloqueo alfa primero (doxazosina 2–16 mg/día o fenoxibenzamina) 10–14 días con sal y líquidos; betabloqueador solo después. Nunca betabloqueo solo (crisis hipertensiva).
- Seguimiento: derivar a endocrinología y cirugía; metanefrinas anuales tras la cirugía y estudio genético familiar.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Una paciente de 40 años presenta episodios paroxísticos frecuentes de cefalea severa, sudoración profusa y taquicardia con cifras tensionales de 220/115 mmHg. Se confirma el diagnóstico de feocromocitoma suprarrenal derecho mediante metanefrinas fraccionadas urinarias elevadas y TC abdominal. Se programa una suprarrenalectomía laparoscópica para dentro de dos semanas. **¿Cuál de los siguientes esquemas farmacológicos preoperatorios representa la conducta correcta y obligatoria?**

A) Iniciar propranolol oral a dosis plenas de inmediato y asociar fenoxibenzamina 24 horas antes del pabellón
B) Iniciar bloqueo alfa-adrenérgico con fenoxibenzamina o doxazosina durante 10 a 14 días, y asociar betabloqueador solo con posterioridad si persiste taquicardia
C) Indicar atenolol oral en monoterapia sin administrar bloqueadores alfa
D) Administrar sulfato de magnesio en infusión y llevar a pabellón de inmediato sin preparación oral
E) Indicar espironolactona asociada a enalapril oral

Respuesta B. Preparación obligatoria: bloqueo alfa completo (fenoxibenzamina o doxazosina) por 10 a 14 días con sal y líquidos para reexpandir el volumen. Solo con el bloqueo alfa establecido se agrega betabloqueador si persiste taquicardia. El betabloqueo previo o aislado deja el alfa-1 sin oposición y precipita una crisis hipertensiva.

4.03.1.024 Tumor testicular

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 13.10 Cáncer de Testículo: Masas Indoloras, Marcadores (AFP, b-hCG, LDH) & Orquiectomía Radical

QUÉ HAY QUE SABER

- Cáncer testicular: tumor sólido más frecuente en hombres de 15–35 años; >95% germinales (seminoma 50–55%); principal factor de riesgo la criptorquidia (4–10 veces).
- Sospecha: masa intratesticular dura, pétrea e indolora que no transilumina; toda masa intratesticular es maligna hasta demostrar lo contrario.
- Primer examen: ecografía testicular Doppler (sensibilidad cercana al 100%) y marcadores antes de operar: AFP, beta-hCG y LDH. AFP elevada indica no seminoma (el seminoma puro nunca la eleva).
- Tratamiento inicial: derivar para orquiectomía inguinal radical con clampeo alto del cordón; prohibidas la punción y la vía escrotal (cambian el drenaje linfático).
- Etapificación con TAC de tórax, abdomen y pelvis; criopreservar semen antes de la quimioterapia (BEP). Curación >90% incluso avanzado; tiene garantía GES.
- Seguimiento: derivar a urología/oncología; controles con marcadores e imágenes por el especialista.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 162

Un paciente de 30 años consulta por aumento de volumen escrotal derecho. Al examen físico se palpa un tumor en relación al testículo derecho. Se solicita ecografía testicular que visualiza una lesión sólida, de 3 cm de diámetro, sin vascularización, que reemplaza al parénquima testicular, sin compromiso del epidídimo. ¿Cuál es la conducta? **¿Cuál es la conducta?**

A) Radioterapia
B) Quimioterapia
C) Orquiectomía radical
D) TAC de abdomen y pelvis
E) Biopsia testicular por punción

Respuesta C. Tumor testicular confirmado con la ecografía: orquiectomía radical, que es a la vez diagnóstica y terapéutica. La punción está prohibida; el TAC se pide después para etapificar.

Pregunta de práctica

Hombre de 25 años con aumento de volumen indoloro del testículo derecho de 2 meses. Masa pétrea de 3,5 cm intratesticular, que no transilumina. La ecografía Doppler muestra una masa sólida hipoecogénica vascularizada de 34 mm. AFP 120 ng/mL (normal <8), beta-hCG 45 mUI/mL y LDH 380 U/L. **¿Cuál es la conducta inicial?**

A) Biopsia por punción transescrotal
B) Orquiectomía inguinal radical con clampeo alto del cordón
C) Enucleación del nódulo por vía escrotal
D) Ecografía de control en 3 meses
E) Quimioterapia con BEP antes de cirugía

Respuesta B. Masa sólida intratesticular con marcadores elevados: tumor germinal no seminomatoso. Se opera por vía inguinal con clampeo alto del cordón. La punción o la vía escrotal están contraindicadas por la diseminación a los ganglios inguinales.

Pregunta de práctica

Hombre de 30 años operado de orquiectomía inguinal. La biopsia informa "seminoma clásico puro", pero la alfafetoproteína es de 350 ng/mL (normal <8) antes y después de la cirugía. **¿Cuál es la implicancia clínica?**

A) Es normal: la mitad de los seminomas puros secretan AFP
B) El seminoma puro nunca produce AFP; se debe tratar como no seminoma
C) La AFP se debe a necrosis tumoral y no cambia la conducta
D) Indica insuficiencia hepática por la anestesia
E) Indica un teratoma maduro benigno

Respuesta B. El seminoma puro no sintetiza AFP. Si está elevada, hay un componente no seminomatoso no identificado (embrionario o saco vitelino) y el paciente se trata como no seminoma, que es radiorresistente y requiere quimioterapia.

4.03.1.025 Urolitiasis

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 13.1 Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea

QUÉ HAY QUE SABER

- Litiasis urinaria: oxalato de calcio 75–80% (radiopaco); ácido úrico radiolúcido (gota, orina ácida); estruvita coraliforme por Proteus (ureasa, orina alcalina); cistina en cistinuria.
- Sospecha: cólico lumbar súbito irradiado a genitales, inquietud sin posición antiálgica, vómitos, puñopercusión positiva y microhematuria. Diferencial clave en adulto mayor: aneurisma aórtico roto.
- Examen de elección: pielo-TAC (TAC sin contraste), sensibilidad y especificidad >95%; ecografía en embarazadas y niños.
- Conducta inicial según tamaño: <5 mm expulsión espontánea en 80–90% (AINE y filtrar orina); 5–10 mm terapia expulsiva con tamsulosina 0,4 mg/día por hasta 4 semanas; >10 mm derivar (LEOC, ureteroscopía o nefrolitotomía percutánea si >20 mm o coraliforme).
- Banderas rojas: fiebre (pionefrosis), monorreno, anuria o dolor refractario: descompresión urgente con doble J o nefrostomía.
- Prevención: ingesta de agua >2,5 L/día para todos; estudio metabólico (orina 24 h) en recurrentes, monorrenos, niños o cálculos no cálcicos; hipercalciuria: tiazida. Seguimiento: derivar a urología si no expulsa.

PREGUNTAS (7)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 150

Un paciente de 45 años presenta un cuadro de cólico renal derecho que es manejado con analgesia. Se realiza una pieloTAC, que muestra la presencia de un cálculo de 4 mm en el uréter derecho, el cual se maneja inicialmente con observación. Sin embargo, luego de 4 semanas no ha presentado expulsión del cálculo a pesar de haberse indicado terapia expulsiva con alfabloqueantes hace dos semanas. La pieloTAC de control muestra mayor dilatación de la vía urinaria en dicha zona, con presencia del cálculo descrito, de 4 mm en el uréter distal, que se informa con una dureza de 800 unidades de Hounsfield. La creatinina de control está en 1,38 mg/dL. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Mantener terapia farmacológica expulsiva y controlar en 2 semanas
B) Realizar la instalación de un catéter “doble J”
C) Administrar antibióticos endovenosos
D) Realizar una ureteroscopía
E) Realizar litotricia (litotripsia) extracorpórea

Respuesta D. Si el cálculo no sale tras cuatro semanas y la vía se dilata más, hay que resolverlo. La ureteroscopía se prefiere para cálculos del uréter distal y muy duros, y cuando la litotripsia extracorpórea no corresponde. La litotripsia se prefiere en uréter alto o medio, de dureza baja o moderada.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 126

Un paciente de 54 años ha presentado varios episodios de cólico renal, con eliminación reiterada de cálculos urinarios. Su examen físico no tiene alteraciones. En sus exámenes destaca creatinina: 1,4 mg/dl y examen de orina con pH: 7,9, glóbulos rojos: 15 x campo, glóbulos blancos: 15 por campo, bacterias en moderada cantidad y cristales de fosfato amónico magnésico (estruvita). El pieloTAC muestra presencia de cálculos coraliformes bilaterales. **¿Qué germen es el agente etiológico, con mayor probabilidad?**

A) Proteus mirabilis
B) Klebsiella oxytoca
C) Pseudomona aureginosa
D) Campilobacter jejuni
E) Escherichia coli

Respuesta A. El Proteus es la causa de los cálculos coraliformes de estruvita. Además, suele alcalinizar la orina.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 64

Un paciente de 34 años presenta su primer episodio de cólico renal. Presenta eliminación espontánea de un pequeño cálculo, el que no es preservado para estudio citoquímico. Actualmente está asintomático y el pieloTAC no observa otras litiasis. **¿Cuál es la conducta más adecuada en este paciente?**

A) Indicar dieta baja en lácteos
B) Iniciar hidroclorotiazida
C) Aumentar la ingesta de agua
D) Realizar litotripsia extracorpórea
E) Realizar estudio metabólico de urolitiasis

Respuesta C. Para evitar la recidiva de las litiasis siempre es útil aumentar la ingesta de agua, con independencia de la causa. Además, en los casos de hipercalciuria sirven las tiazidas y, en los casos de hiperoxaluria o hiperuricosuria, sirve la dieta. En el caso de ser por estruvita, también se debe tratar con antibióticos.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 170 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 42 años presenta eliminación de un cálculo en orina, el cual no pudo recuperar para análisis. Se realiza estudio metabólico en orina de 24 horas con calcio, fósforo, citrato y uratos, todos dentro del rango normal, al igual que su perfil bioquímico en sangre. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Aumentar la ingesta de agua
B) Iniciar alopurinol oral
C) Realizar litrotricia extracorpórea
D) Indicar dieta baja en lácteos
E) Indicar dieta rica en vegetales

Respuesta A. Prevención de la Litiasis Urinaria: La medida más importante para prevenir la formación de cálculos renales es aumentar la ingesta de agua. Dependiendo del tipo de cálculo y las alteraciones metabólicas, se pueden recomendar medidas adicionales como tiazidas para la hipercalciuria, alopurinol para la hiperuricemia/hiperuricosuria, y una dieta baja en proteínas animales para la hiperoxaluria.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 11 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 78 años ha presentado eliminación de cálculos urinarios a repetición. Se solicitan exámenes de orina que muestran sedimento con 20 glóbulos rojos por campo, 12 leucocitos por campo, bacterias en abundante cantidad y cristales abundantes de fosfato de amonio magnesiano. El urocultivo está pendiente. Se solicita una pieloTAC, que muestra cálculos coraliformes bilaterales. El urocultivo, probablemente resultará positivo, ¿para qué bacteria?

A) Pseudomona aureginosa
B) Escherichia coli
C) Campilobacter jejuni
D) Proteus mirabilis
E) Enterobacter cloacae

Respuesta C. La alternativa correcta es la C (Campilobacter jejuni). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Pseudomona aureginosa, Escherichia coli) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 48 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 83 años, diabético e hipertenso, consulta por dolor en el flanco derecho, asociado a 2 episodios de vómitos alimentarios. En su examen físico, tiene frecuencia cardíaca: 80x', PA: 120/80 mmHg y abdomen sin signos peritoneales. Se solicita TAC de abdomen y pelvis que se muestra a continuación (fuente: Radiopaedia): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Colitis isquémica
B) Pancreatitis aguda
C) Litiasis ureteral
D) Diverticulitis aguda
E) Infarto esplénico

Respuesta C. Diagnóstico Diferencial de Cólico Renal: El cuadro clínico sugiere un cólico renal. Sin embargo, en un paciente adulto mayor con factores de riesgo cardiovascular, se debe considerar un aneurisma aórtico abdominal roto. En la imagen, se observa un cálculo en el uréter, confirmando el diagnóstico de urolitiasis.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 101 · texto original del banco, sin revisar

Paciente con litiasis a repetición, orina inflamatoria y cristales de fosfato magnesio amónico con litiasis coraliforme. ¿Qué microorganismo crecerá en el urocultivo?

A) Escherichia coli
B) Klebsiella pneumoniae
C) Pseudomonas aeruginosa
D) Staphylococcus saprophyticus
E) Proteus mirabilis

Respuesta E. La alternativa correcta es la E (Proteus mirabilis). Proteus mirabilis. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentaci

4.03.1.026 Uropatía alta

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 13.1 Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea

QUÉ HAY QUE SABER

- Uropatía obstructiva alta: obstrucción ureteral o pieloureteral (cálculo, estenosis, tumor, compresión extrínseca por cáncer pélvico) con hidroureteronefrosis; bilateral o en monorreno produce IRA postrenal.
- Diagnóstico específico: pielo-TAC sin contraste para litiasis o ecografía renal (hidronefrosis); TAC con contraste si se sospecha causa tumoral y la función lo permite.
- Obstrucción infectada (fiebre, calofríos, hipotensión): urgencia; hemocultivos, urocultivo, volumen, antibióticos EV y descompresión urgente con catéter doble J o nefrostomía percutánea.
- El tratamiento definitivo del cálculo (LEOC o ureteroscopía) se difiere hasta resolver la infección, porque manipularlo infectado agrava la sepsis.
- Obstrucción ureteral bilateral tumoral sin posibilidad de doble J retrógrado: nefrostomía percutánea.
- Seguimiento: derivar a urología; vigilar poliuria postobstructiva y electrolitos tras desobstruir.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 48 años con dolor lumbar derecho tipo cólico de 2 días, ahora con fiebre de 39 °C, calofríos y PA 95/60 mmHg. La TAC sin contraste muestra un cálculo de 8 mm en el uréter proximal derecho con hidronefrosis moderada. Creatinina 1,6 mg/dL. Se inician hemocultivos, volumen y antibióticos endovenosos. **¿Cuál es la conducta más importante a continuación?**

A) Tamsulosina y esperar expulsión espontánea
B) Litotricia extracorpórea de urgencia
C) Derivación urgente de la vía urinaria (catéter doble J o nefrostomía percutánea)
D) Ureteroscopía con extracción del cálculo en el mismo acto
E) Completar 14 días de antibióticos y luego reevaluar

Respuesta C. Una pielonefritis obstructiva (uropatía obstructiva alta infectada) es una urgencia urológica: además de antibióticos y soporte, requiere descomprimir la vía urinaria de inmediato con catéter doble J o nefrostomía. El tratamiento definitivo del cálculo (litotricia o ureteroscopía) se difiere hasta resolver la infección, porque manipularlo infectado agrava la sepsis.

4.03.1.027 Uropatía obstructiva baja

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 13.2 Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía · Tema 13.3 Hiperplasia Prostática Benigna (HPB): IPSS, Tacto Rectal, Tamsulosina/Finasteride & RTUP

QUÉ HAY QUE SABER

- Uropatía obstructiva baja: obstrucción infravesical por HPB (la más frecuente), cáncer de próstata, estenosis uretral, coágulos, cálculos o vejiga neurogénica; fármacos anticolinérgicos y opiáceos la descompensan.
- Sospecha: síntomas de vaciado, globo vesical, incontinencia por rebalse (goteo continuo) y, si progresa, hidronefrosis bilateral con alza de creatinina (IRA postrenal).
- Primera medida: sonda Foley 16–18 Fr con descompresión continua y completa (el clampeo intermitente está obsoleto); con trauma uretral o sonda imposible, cistostomía suprapúbica.
- Vigilar diuresis postobstructiva si se evacúan >1.000 mL: poliuria, hipovolemia e hipokalemia; controlar diuresis y electrolitos.
- Estudio: ecografía renal y vesicoprostática con residuo postmiccional, creatinina, APE (diferido) y uroflujometría.
- Seguimiento: derivar a urología para tratar la causa (alfabloqueador, cirugía de HPB, uretrotomía).

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Varón de 69 años con retención urinaria aguda de 12 horas es sondado con éxito en urgencias mediante sonda Foley, evacuándose de forma inmediata 1.400 mL de orina clara. El paciente refiere alivio inmediato del dolor. **¿Cuál es la complicación fisiopatológica que debe monitorizarse con mayor atención en las primeras 24 horas?**

A) Reflejo vasovagal sostenido con paro cardíaco
B) Síndrome de diuresis post-obstructiva con deshidratación e hipokalemia
C) Estenosis uretral isquémica precoz
D) Necrosis tubular aguda anúrica irreversible
E) Hematuria ex vacuo masiva con shock hipovolémico

Respuesta B. Tras la descompresión de una obstrucción severa y prolongada, sobre todo con más de 1.000 mL, puede aparecer el síndrome de diuresis postobstructiva: pérdida del gradiente medular y excreción de la urea retenida, con diuresis masiva, deshidratación e hipokalemia. La hematuria ex vacuo con shock es un mito.

Pregunta de práctica

Hombre de 76 años con síntomas urinarios bajos de años, sin tratamiento, consulta por goteo urinario continuo, día y noche, de 2 meses, y decaimiento. Al examen hay un globo vesical palpable indoloro. Creatinina 2,8 mg/dL (hace 1 año 1,0 mg/dL). La ecografía muestra hidroureteronefrosis bilateral y vejiga distendida con 900 mL. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Descompresión vesical con sonda Foley, control de diuresis y electrolitos por riesgo de poliuria postobstructiva, y derivar a urología
B) Oxibutinina por incontinencia de urgencia
C) Nefrostomía percutánea bilateral urgente
D) Iniciar tamsulosina y control en 3 meses
E) Biopsia renal por insuficiencia renal de causa desconocida

Respuesta A. El goteo continuo con globo vesical es incontinencia por rebalse, y la hidronefrosis bilateral con alza de creatinina indica uropatía obstructiva baja con daño renal. Se descomprime la vejiga con sonda, vigilando la poliuria postobstructiva y los electrolitos, y luego se trata la causa. La nefrostomía no es necesaria si la obstrucción es infravesical.

4.03.1.028 Varicocele

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 13.7 Patología Escrotal No Dolorosa: Varicocele, Hidrocele, Espermatocele & Quistes

QUÉ HAY QUE SABER

- Varicocele: dilatación del plexo pampiniforme, casi siempre izquierdo (vena espermática drena en ángulo recto a la renal izquierda); 'bolsa de gusanos' sobre el testículo, aumenta con Valsalva y se colapsa acostado.
- Es la causa tratable más frecuente de infertilidad masculina (calor e hipoxia dañan la espermatogénesis); no transilumina. Eco Doppler confirma si hay duda.
- Bandera roja: varicocele derecho aislado, de aparición brusca después de los 40 años o que no colapsa en decúbito: TAC de abdomen y pelvis para descartar tumor renal o retroperitoneal.
- Varicocelectomía si hay infertilidad con espermiograma alterado, atrofia testicular (en adolescentes) o dolor persistente; si no, observar.
- Seguimiento: control clínico del volumen testicular en adolescentes y espermiograma en adultos con deseo de fertilidad.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 148

Un adolescente de 15 años presenta dolor frecuente del testículo izquierdo. Al examen físico se palpa aumento de volumen peritesticular, compatible con un varicocele y además se palpa el testículo izquierdo de menor tamaño que el testículo derecho. Se solicita una ecografía testicular que muestra una dilatación patológica del plexo pampiniforme. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Observa evolución hasta que complete su desarrollo puberal
B) Realizar varicosectomía
C) Solicitar espermiograma
D) Realizar biopsia testicular
E) Solicitar cariograma y niveles de testosterona, LH y FSH

Respuesta B. Tiene indicación de ligadura del plexo pampiniforme, tanto por la atrofia testicular como por el dolor.

Pregunta de práctica

Hombre de 58 años, sano, nota hace 3 semanas un aumento de volumen indoloro en el hemiescroto derecho. Se palpa una masa varicosa tortuosa en el cordón derecho que, al acostarlo en decúbito dorsal, sigue ingurgitada y no se colapsa. **¿Cuál es la conducta diagnóstica prioritaria?**

A) Varicocelectomía subinguinal electiva
B) Espermiograma para evaluar fertilidad
C) TAC de abdomen y pelvis con contraste
D) Tranquilizar: es un proceso benigno por la edad
E) Suspensorio escrotal y control en 6 meses

Respuesta C. Varicocele derecho, de aparición tardía y que no se colapsa en decúbito: obstrucción venosa fija hasta demostrar lo contrario. Se busca un carcinoma renal con trombo en la vena renal o la cava, o una masa retroperitoneal, con TAC de abdomen y pelvis.

Situaciones clínicas de urgencia 9 códigos

4.03.2.001 Cólico renal

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 13.1 Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea

QUÉ HAY QUE SABER

- Cólico renal: dolor lumbar súbito, intenso, paroxístico, irradiado a flanco y genitales, con inquietud, vómitos, puñopercusión positiva y microhematuria.
- Confirmación: pielo-TAC (TAC sin contraste), examen de elección; ecografía en embarazadas y niños. No pedir uro-TAC ni urografía para el cólico.
- Analgesia sin esperar el TAC: AINE EV, ketorolaco 30 mg o ketoprofeno 100 mg; opioide (tramadol o morfina) solo de rescate. Evitar sueros rápidos y diuréticos.
- Alta con AINE oral; cálculo 5–10 mm: tamsulosina 0,4 mg/día y control en 2–4 semanas; <5 mm observar y filtrar orina.
- Hospitalizar y descomprimir (doble J o nefrostomía) si hay fiebre, monorreno, anuria/falla renal, dolor refractario o vómitos incoercibles.
- Seguimiento: derivar a urología si no expulsa en 4 semanas, cálculo >10 mm o complicado.

PREGUNTAS (7)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 158

Paciente con hidronefrosis izquierda severa por urolitiasis y antecedente de nefrectomía derecha previa (monorreno). Sin infección activa. **¿Cuál es el manejo más adecuado?**

A) Catéter doble J para aliviar la obstrucción y preservar la función renal
B) Nefrectomía izquierda
C) Nefrostomía percutánea de urgencia
D) Litotricia extracorpórea sin derivación
E) Solo analgesia y observar

Respuesta A. Monorreno con obstrucción ureteral por cálculo: es una IRA postrenal y una urgencia urológica. El catéter doble J descomprime el sistema colector y preserva el único riñón funcionante. Observar o litotriptar sin derivar deja al riñón obstruido.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 100

Un paciente de 26 años presenta un cuadro de dolor lumbar, asociado a inquietud motora de 5 día de evolución. Hace 2 días se agrega fiebre y compromiso del estado general, más vómitos alimentarios. Al examen físico se aprecia FC: 105x', PA: 100/70 mmHg, Tº: 38ºC, puño percusión positiva a izquierda. Se solicita pieloTAC que muestra imagen cálcica en el tercio medio del uréter izquierdo, con dilatación de la vía urinaria proximal y edema perirrenal. Su sedimento de orina muestra 40 leucocitos por campo, bacterias y cristales en moderada cantidad. Se inicia tratamiento antibiótico endovenoso y se administran cristaloides. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Litotripsia extracorpórea
B) Nefrolitotomía percutánea
C) Extracción quirúrgica abierta
D) Catéter doble jota
E) Litotomía ureteroscópica

Respuesta D. PNA sobre una vía urinaria obstruida por un cálculo (pionefrosis): emergencia urológica. Además de antibióticos y volumen, hay que descomprimir la vía urinaria, con un catéter doble J (o nefrostomía percutánea si no es posible). El cálculo se trata después, con la infección resuelta.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 56

Un paciente de 27 años, sin antecedentes, consulta por dolor en flanco izquierdo de 2 horas de evolución tipo cólico, irradiado a genitales, náuseas y vómitos, sudoración y hematuria. Al examen físico se encuentra inquieto, con puño percusión positiva a izquierda. **El fármaco de elección para el manejo de este paciente es:**

A) Ketorolaco
B) Acetaminofeno
C) Pargeverina
D) Tramadol
E) Clonixinato de lisina

Respuesta A. Cólico renal: el fármaco de primera línea es un AINE endovenoso, como el ketorolaco.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 33

Un paciente de 32 años presenta un cuadro de cólico renal, asociado a microhematuria en el sedimento de orina. **¿Cuál es el examen de elección para el estudio de este paciente?**

A) UroTAC
B) PieloTAC
C) Pielografía de eliminación intravenosa
D) Ecografía
E) Radiografía simple

Respuesta B. El cólico renal se estudia con PieloTAC (TAC sin contraste). El UroTAC se utiliza como estudio de la hematuria, después de descartar TU, cuando se sospecha cáncer, ya que dibuja bien la vía urinaria.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 27

Un paciente de 22 años presenta un cuadro de dolor a la fosa lumbar derecha, irradiado al flanco derecho intenso ipsilateral y asociado a vómitos, que ha manejado con analgésicos. Evoluciona dos días después con malestar general y fiebre de 38,8°C. Su sedimento de orina muestra Se solicita pieloTAC, que muestra presencia de un cálculo de 9 mm, en el tercio distal del uréter derecho, con presencia de hidroureteronefrosis ipsilateral. **Además de iniciar analgésicos y antibióticos, ¿Cuál es la conducta más adecuada en este momento?**

A) Realizar nefrolitotomía abierta
B) Realizar nefrolitotomía percutánea
C) Realizar litotripsia extracorpórea
D) Instalar un catéter doble J
E) Indicar tratamiento médico expulsor

Respuesta D. Cólico con fiebre e hidroureteronefrosis es una pionefrosis, una urgencia: se descomprime la vía con un catéter doble J. El cálculo se trata después, cuando la infección está controlada.

Pregunta de práctica

Hombre de 34 años consulta por dolor lumbar derecho súbito de 3 horas, irradiado a testículo, con vómitos e intensa inquietud. PA 155/95 mmHg, FC 102 lpm, T° 36,7 °C. Puñopercusión derecha muy dolorosa. Sedimento de orina: 50 a 60 eritrocitos por campo. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Ketorolaco endovenoso y luego pielotac
B) Morfina endovenosa y esperar la ecografía
C) Hidratación rápida con 2 litros de suero y furosemida
D) Urografía de eliminación antes de analgesiar
E) Hospitalizar para descompresión con doble J

Respuesta A. Es un cólico renal típico, afebril. La primera línea es un AINE endovenoso, que actúa sobre el mecanismo. Luego se pide pielotac para medir el cálculo. No se difiere la analgesia, no se fuerzan fluidos ni diuréticos en la fase aguda y la descompresión se reserva para fiebre, monorreno, anuria o dolor refractario.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 20 · texto original del banco, sin revisar

¿Cuál es el examen de elección para el enfrentamiento inicial de un paciente de 22 años, en su primer cuadro de cólico renal, con microhematuria?

A) Pielografía de eliminación
B) UroTAC
C) PieloTAC
D) Ecografía renal y vesical
E) Radiografía simple

Respuesta C. El diagnóstico de cólico renal es clínico. El pieloTAC es el examen de elección para identificar la ubicación y tamaño del cálculo renal, de modo de determinar si se observa (menor a 1 cm) o si se saca mediante LEC u otra intervención. El UroTAC, en cambio, se usa para estudiar el trauma renal y la hematuria, en que se sospecha cáncer, antes de la cistoscopía.

4.03.2.002 Hematuria masiva

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 13.15 Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas

QUÉ HAY QUE SABER

- Hematuria masiva: sangrado urinario con coágulos y posible retención por coágulos (globo vesical doloroso) o compromiso hemodinámico; en fumador mayor, pensar en cáncer vesical.

- Otras causas: HPB (hematuria prostática), tumor renal, litiasis, trauma, cistitis actínica o hemorrágica, anticoagulación.
- Manejo: ABC, vías venosas, hemograma, pruebas de coagulación, grupo y transfusión si corresponde; corregir anticoagulación.
- Sonda vesical de 3 vías de grueso calibre (20–24 Fr), lavado manual para evacuar coágulos e irrigación vesical continua con suero fisiológico; una sonda fina se obstruye.
- Si no cede con irrigación: cistoscopía urgente con evacuación de coágulos y fulguración.
- Seguimiento: derivar a urología para estudio etiológico con uro-TAC y cistoscopía.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 72 años, fumador, consulta por hematuria macroscópica con coágulos de 12 horas y ahora no puede orinar. Al examen tiene globo vesical doloroso. Está hemodinámicamente estable, Hb 11 g/dL. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Instalar sonda Foley de 2 vías de calibre fino
B) Instalar sonda vesical de 3 vías de grueso calibre, evacuar coágulos e iniciar irrigación vesical continua con suero fisiológico
C) Cistostomía suprapúbica por punción
D) Indicar ácido tranexámico y alta con control urológico
E) Cistoscopía diagnóstica ambulatoria en 1 mes

Respuesta B. La hematuria masiva con retención por coágulos se maneja con sonda de 3 vías de grueso calibre (20 a 24 Fr), lavado manual para evacuar coágulos e irrigación continua, además de soporte y corrección de coagulopatía. Una sonda fina se obstruye con coágulos. Luego se estudia la causa (en fumador mayor, descartar cáncer vesical con cistoscopía y uroTAC).

4.03.2.003 Parafimosis

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: uro-16

QUÉ HAY QUE SABER

- Parafimosis: prepucio retraído detrás del glande que no vuelve a su posición y forma un anillo constrictor, con glande edematoso y doloroso; típicamente iatrogénica tras sonda o examen.
- Es una urgencia por riesgo de isquemia del glande (violáceo o necrótico indica gravedad).
- Reducción manual: analgesia (bloqueo peneano o anestesia tópica), compresión sostenida del glande para reducir el edema y luego empujar el glande con los pulgares mientras índices y medios traccionan el prepucio hacia distal.
- Si la reducción fracasa: incisión dorsal del anillo constrictor; no aplicar calor (aumenta el edema).
- Prevención: reponer siempre el prepucio tras sondear o examinar.
- Seguimiento: derivar a urología/cirugía para circuncisión electiva diferida.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 70 años hospitalizado con sonda Foley. Al día siguiente de instalada, la enfermera nota el glande edematoso y violáceo con un anillo prepucial retraído y tenso detrás del glande, muy doloroso. **¿Cuál es el diagnóstico y la conducta inicial?**

A) Balanitis; antifúngico tópico
B) Parafimosis; circuncisión inmediata en todos los casos
C) Fimosis; corticoide tópico
D) Parafimosis; reducción manual del prepucio previa compresión del edema y analgesia
E) Gangrena de Fournier; aseo quirúrgico

Respuesta D. La parafimosis es el prepucio retraído que no vuelve a su posición y forma un anillo constrictor, típicamente iatrogénica tras sonda o examen sin reponer el prepucio. Es una urgencia: se reduce manualmente tras analgesia y compresión del edema; si fracasa, incisión dorsal del anillo. La circuncisión se plantea en forma diferida.

4.03.2.004 Priapismo

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: uro-16

QUÉ HAY QUE SABER

- Priapismo: erección prolongada >4 horas no relacionada con estímulo sexual; el isquémico (bajo flujo) es el más frecuente y es una urgencia: cuerpos cavernosos rígidos y dolorosos, glande blando.
- Causas: drogas vasoactivas intracavernosas, trazodona, antipsicóticos, cocaína, anemia falciforme, leucemia; el no isquémico (alto flujo) sigue a trauma perineal, es indoloro y semirrígido.
- Diagnóstico específico: gasometría de sangre cavernosa (isquémico: sangre oscura, pO2 <30, pH <7,25) o eco Doppler.
- Manejo inicial del isquémico: analgesia, bloqueo peneano, aspiración de cuerpos cavernosos e irrigación con suero; si no cede, fenilefrina intracavernosa con monitorización.
- Después de 24–48 h el riesgo de fibrosis y disfunción eréctil permanente es alto: derivar a urología urgente (shunt quirúrgico si fracasa).
- El no isquémico no es urgencia: derivar a urología (observación o embolización selectiva).

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 62

Hombre de 34 años presenta erección dolorosa desde hace 8 horas. Al examen se corrobora erección completa, con turgencia solo de los cuerpos cavernosos y glande y cuerpo esponjoso blandos. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Aplicar hielo en la zona genital
B) Realizar derivación cavernoesponjosa de urgencia
C) Administrar atropina intracavernosa
D) Administrar analgésicos endovenosos
E) Administrar fenilefrina intracavernosa

Respuesta E. Erección dolorosa de más de 4 horas con cuerpos cavernosos rígidos es un priapismo isquémico (de bajo flujo), una urgencia. Se trata con aspiración de sangre de los cuerpos cavernosos e inyección intracavernosa de fenilefrina (agonista alfa). Los shunts quirúrgicos se reservan para el fracaso del manejo intracavernoso.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 66 · texto original del banco, sin revisar

Un hombre de 34 años presenta erección dolorosa, desde hace 8 horas. Al examen tiene cuerpos cavernosos duros, pero con glande y cuerpos esponjosos blandos. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Aplicar paños fríos en la zona genital
B) Fenilefrina endovenosa
C) Vaciamiento quirúrgico de los cuerpos cavernosos.
D) Drenaje con suero fisiológico frío intracavernoso
E) Fenilefrina intracavernosa Respuesta: (Nota: La imagen se corta antes de mostrar la explicación o la respuesta correcta, pero la conducta inicial para un priapismo isquémico suele ser el drenaje y la inyección de fenilefrina intracavernosa).

Respuesta C. Conducta / Tratamiento indicado: Vaciamiento quirúrgico de los cuerpos cavernosos. (opción C). La resolución quirúrgica urgente constituye la única medida definitiva capaz de controlar el foco séptico, revertir la isquemia o evitar la muerte materna/fetal frente a este compromiso clínico severo.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 94 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 24 años, con antecedente de consumo frecuente de cocaína, presenta dolor peneano de 5 horas de evolución asociado a una erección constante. Al examen Fsico se obje8va erección de los cuerpos cavernosos, con flacidez del glande y el cuerpo esponjoso. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Administrar adrenalina intracavernosa
B) Propranolol vía oral
C) Doxasozina vía oral
D) Derivación cavernoesponjosa quirúrgica
E) Administrar fenilefrina intracavernosa

Respuesta E. Tiene un priapismo isquémico o verdadero (erección dolorosa y mantenida, limitada a los cuerpos cavernosos). El tratamiento sigue el siguiente orden: 1. Fenilefrina intracavernosa, 2. Procedimientos invasivos (drenaje de los cuerpos cavernosos con suero fisiológico o derivación cavernoesponjosa). Además, se debe buscar la presencia de leucemia y anemia de células falciformes (rara en Chile), aunque

4.03.2.005 Prostatis aguda

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 13.13 Prostatitis Aguda y Crónica: Peligro de Sepsis, Antibióticos Prolongados & Prostatodinia

QUÉ HAY QUE SABER

- Prostatitis aguda: fiebre alta con calofríos, disuria, dolor perineal al sentarse y lumbosacro; próstata caliente, tumefacta y muy dolorosa al tacto rectal suave. Agentes: E. coli 75–80% y enterobacterias.
- Diagnóstico: clínica + urocultivo (sin masaje); el masaje prostático está contraindicado por riesgo de bacteriemia y shock. El APE se eleva y debe repetirse tras tratar.
- Ambulatorio: ciprofloxacino 500 mg c/12 h por 3–4 semanas (fluoroquinolonas y cotrimoxazol penetran la próstata; la mayoría de betalactámicos no).
- Con sepsis o intolerancia oral: hospitalizar, ceftriaxona EV ± gentamicina y completar 3–4 semanas.
- Retención urinaria: cistostomía suprapúbica por punción; evitar sonda uretral.
- Seguimiento: derivar si no responde (eco transrectal o TAC para absceso prostático) o en crónicas; categoría crónica bacteriana 6–12 semanas.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 101

Un paciente de 56 años consulta por disminución del calibre miccional, asociado a disuria de esfuerzos de 3 meses de evolución. Hace 7 días se agrega disuria, polaquiuria y malestar. Se solicita APE, que resulta 14,7 ng/ml (valor normal: menor a 4 ng/ml). El tratamiento inicial más adecuado es: **¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?**

A) Tamsulosina
B) Nitrofurantoína
C) Ciprofloxacino
D) Dutasteride
E) Doxazosina

Respuesta C. La clínica de infección urinaria con APE muy elevado sugiere prostatitis aguda. Se trata con ciprofloxacino, y el APE se repite después de tratarla.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 48

Un hombre de 50 años consulta por disuria dolorosa y fiebre, asociada a malestar general, polaquiuria y dolor perineal. Al examen físico presenta fiebre alta, con hemodinamia estable. Se realizan exámenes entre los que destacan sedimento de orina con leucocitos +++, bacterias ++. Su urocultivo está pendiente. ¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada?
¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada?

A) Ciprofloxacino
B) Amoxicilina
C) Claritromicina
D) Nitrofurantoína
E) Doxiciclina

Respuesta A. Fiebre, disuria y dolor perineal en un hombre sugieren prostatitis aguda o una infección urinaria febril. El ciprofloxacino cubre ambas.

Pregunta de práctica

Hombre de 46 años, fiebre de 39,3 °C con calofríos, dolor lumbosacro, dolor punzante en el periné al sentarse y disuria de 24 horas. Sin globo vesical. Al tacto rectal suave, próstata discretamente aumentada, muy caliente y exquisitamente dolorosa. **¿Cuál es la conducta adecuada?**

A) Masaje prostático para obtener secreción
B) Urocultivo y ciprofloxacino por 4 semanas
C) Nitrofurantoína por 7 días
D) Antiinflamatorios y observación
E) Biopsia prostática

Respuesta B. Es una prostatitis bacteriana aguda. Se toma urocultivo sin masaje y se inicia una fluoroquinolona de buena penetración prostática por 3 a 4 semanas. El masaje puede causar bacteriemia y shock séptico.

Pregunta de práctica

Hombre de 42 años con 24 horas de fiebre de 39,5 °C, calofríos, dolor perineal que empeora al sentarse y disuria. Al tacto rectal suave, próstata caliente, tumefacta y muy dolorosa. **¿Cuál de las siguientes acciones está formalmente contraindicada?**

A) Tomar urocultivo de chorro medio antes de los antibióticos
B) Realizar masaje prostático vigoroso para obtener secreción
C) Administrar antipiréticos y AINE para el dolor
D) Indicar ciprofloxacino oral por 4 semanas
E) Realizar cistostomía suprapúbica si hay retención aguda de orina

Respuesta B. En la prostatitis aguda el masaje está contraindicado: comprimir una glándula infectada puede diseminar bacterias a la sangre y causar shock séptico. El diagnóstico se hace con la clínica y el urocultivo.

4.03.2.006 Retención urinaria aguda

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 13.2 Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía

QUÉ HAY QUE SABER

- Retención urinaria aguda: imposibilidad de orinar con dolor hipogástrico y globo vesical (masa mate suprapúbica); causa más frecuente HPB descompensada por anticolinérgicos, antihistamínicos, opiáceos o alcohol.
- Antes de sondar preguntar por trauma: uretrorragia, hematoma perineal o fractura de pelvis contraindican la sonda (cistostomía y uretrografía retrógrada).
- Sin trauma: sonda Foley 16–18 Fr con lidocaína gel, avanzar sin forzar, inflar el balón con agua bidestilada solo tras ver orina; descompresión continua y completa.
- Si la sonda no pasa o sangra (estenosis, falsa vía) o hay prostatitis aguda: cistostomía suprapúbica por punción.
- Vigilar diuresis postobstructiva si se evacúan >1.000 mL (poliuria, hipovolemia, hipokalemia).
- Después: iniciar tamsulosina (alfabloqueador) y derivar a urología para estudiar la causa; RAO repetida o refractaria es indicación de cirugía de HPB.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 19

Hombre de 70 años con HPB conocida llega a urgencias con incapacidad de orinar desde hace 8 horas, vejiga palpable en hipogastrio y dolor intenso. **¿Cuál es el manejo inicial de elección?**

A) Sonda Foley vesical
B) Diurético EV
C) Alfa-bloqueador oral y esperar
D) Cistostomía suprapúbica inmediata
E) Cateterismo intermitente

Respuesta A. Retención urinaria aguda: manejo inmediato = sonda Foley para drenaje vesical. Alivia el dolor y previene daño renal. Cistostomía solo si falla la sonda. Alfa-bloqueador se agrega DESPUÉS del episodio agudo para prevención de recurrencia.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 5

Un paciente de 68 años consulta por imposibilidad de orinar asociada a dolor abdominal. Refiere que desde hace 3 días presenta dificultades en la micción que progresaron hasta la anuria en las últimas 24 horas. Al examen físico se observa sudoroso, con frecuencia cardíaca de 100 lpm y quejumbroso. El examen abdominal demuestra matidez a la percusión hipogástrica y dolor a la palpación abdominal baja sin signos peritoneales. Tiene antecedente de una resección transuretral hace 10 años por uropatía obstructiva baja asociada a hiperplasia prostática benigna. Se intenta instalar una sonda Foley número 18 por uretra; sin embargo, se encuentra un tope a los 6 cm, con imposibilidad de pasar la sonda y, luego, uretrorragia moderada. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Cistostomía abierta
B) Intentar instalar una sonda de menor calibre
C) UroTAC
D) Cistostomía suprapúbica
E) Uretrocistografía

Respuesta D. Se trata de una retención urinaria aguda, probablemente por estenosis uretral (post RTU) o recurrencia de hiperplasia prostática. El manejo inicial es sondaje vesical; sin embargo, al fracasar 2 a 3 intentos o al producirse uretrorragia (sugestiva de lesión uretral o falsa vía), la conducta correcta es realizar una cistostomía suprapúbica percutánea para descompresión vesical.

Pregunta de práctica

Hombre de 72 años con dolor intenso en el bajo vientre e imposibilidad de orinar desde hace 14 horas, tras tomar clorfenamina por un resfrío. Está taquicárdico y sudoroso. Se palpa una masa dolorosa y mate en el hipogastrio, 4 cm sobre el pubis. No hay trauma ni sangre en el meato. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Cistostomía suprapúbica por punción
B) Sonda Foley transuretral, con descompresión continua
C) Sonda Foley con clampeo cada 300 mL
D) Solicitar uretrocistografía retrógrada antes de sondar
E) Furosemida endovenosa y observar

Respuesta B. Es una retención aguda de orina por un antihistamínico con efecto anticolinérgico, sobre una hiperplasia prostática probable. Sin trauma ni uretrorragia, la primera maniobra es la sonda Foley, con descompresión continua y completa. El clampeo fraccionado no se usa, y se registra el volumen evacuado para vigilar la diuresis postobstructiva.

4.03.2.007 Torsión testicular

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 13.5 Torsión Testicular vs Torsión de Hidátide: Doppler Testicular & Exploración Quirúrgica <6h

QUÉ HAY QUE SABER

- Torsión testicular: adolescente (12–18 años) con dolor testicular brusco y desgarrador, a menudo durmiendo, con náuseas y vómitos, sin fiebre ni disuria; anomalía en badajo de campana bilateral.
- Examen: reflejo cremastérico abolido (sensibilidad >95%), testículo ascendido y horizontal (Gouverneur) y Prehn negativo (elevarlo no alivia).
- Viabilidad >90% si se opera antes de 6 horas: ante sospecha alta, exploración quirúrgica inmediata sin esperar imágenes; el eco Doppler solo si la duda es intermedia y no retrasa.
- Destorsión manual (hacia afuera, 'abrir un libro') solo como puente; no reemplaza la cirugía.
- En pabellón: destorsión y orquidopexia; siempre fijar también el testículo contralateral; orquiectomía si no es viable.
- Diferencial: torsión de hidátide (7–12 años, dolor gradual en polo superior, punto azul, cremastérico presente): reposo y AINE. Seguimiento: derivar a urología/cirugía infantil.

PREGUNTAS (7)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 44

Un paciente de 16 años presenta dolor testicular derecho intenso, de inicio súbito, asociado a náuseas. Al examen se palpa el testículo derecho muy doloroso y aumentado de tamaño. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Torsión testicular
B) Torsión de la hidátide
C) Infarto testicular
D) Orquiepididimitis
E) Trombosis de varicocele

Respuesta A. Cuadro clásico de torsión testicular. La edad de adolescente orienta más a torsión del cordón que a hidátide, que es de niños más chicos.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 158

Un paciente de 16 años, sin antecedentes, consulta por dolor testicular que inició hace una hora, asociado a náuseas, vómitos y sudoración. Al examen físico se aprecia testículo derecho ascendido respecto al contralateral y escaso eritema circundante. **La conducta más adecuada en este caso es:**

A) Realizar ecografía testicular
B) Indicar doxiciclina y cirpofloxacino
C) Indicar ketorolaco endovenoso y suspensión testicular
D) Realizar exploración quirúrgica inmediata
E) Solicitar exámenes generales, parámetros inflamatorios y sedimento de orina, luego decidir conducta según resultados

Respuesta D. Testículo agudo con sospecha de torsión: exploración quirúrgica inmediata. No se esperan imágenes ni exámenes.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 91

Adolescente de 13 años quien consulta por dolor inguinal y testicular izquierdo, intenso, de 45 minutos de evolución, irradiado a hipogastrio y acompañado de náuseas y vómitos. Al examen físico está afebril, con escroto enrojecido, testículo retraído y doloroso a la palpación. **¿Cuál es la conducta a seguir?**

A) Administrar AINES
B) Administrar antibióticos
C) Cirugía
D) Realizar suspensión testicular
E) Solicitar ecografía testicular

Respuesta C. Es una torsión testicular, o al menos un testículo agudo, y se maneja con exploración quirúrgica.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 97

Un paciente de 19 años consulta por dolor en el testículo izquierdo, de inicio brusco y que se ha asociado a vómitos y malestar general. Al examen físico se aprecia testículo izquierdo edematoso, muy doloroso y ascendido. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar exploración quirúrgica escrotal
B) Realizar ecografía doppler testicular
C) Realizar pieloTAC
D) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
E) Indicar reposo y analgésicos

Respuesta A. Todo testículo agudo se explora, más aún a esta edad, en que se sospecha torsión.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 94

Un hombre de 16 años presenta dolor testicular intenso, que inició hace 8 horas. Tiene EVA 8/10 y al examen testicular se constata testículo derecho muy doloroso, que no mejora con la suspensión testicular. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Antibióticos orales
B) Doppler testicular
C) Analgésicos orales
D) Antibióticos endovenosos
E) Exploración quirúrgica

Respuesta E. Dolor testicular intenso en un adolescente que no mejora al elevar el testículo (Prehn negativo): torsión hasta demostrar lo contrario. Se explora. Con 8 horas, el tiempo ya corre en contra.

Pregunta de práctica

Adolescente de 14 años llega a las 4 AM por dolor testicular izquierdo brutal de 2 horas, que lo despertó, con dos vómitos. Afebril. El testículo izquierdo está doloroso, ascendido y horizontalizado. El reflejo cremastérico izquierdo está abolido y elevar el testículo no alivia el dolor. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Ecografía Doppler testicular antes de decidir
B) Exploración quirúrgica urgente y orquidopexia bilateral
C) Ceftriaxona y doxiciclina con control en 24 horas
D) Analgésicos, suspensorio escrotal y alta
E) Reposo y AINE por torsión de hidátide

Respuesta B. Cuadro típico de torsión del cordón: adolescente, inicio brusco nocturno, vómitos, Gouverneur positivo, Prehn negativo y cremastérico abolido, a solo 2 horas. Se explora de inmediato, sin esperar imágenes, y se fijan ambos testículos.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 137 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 18 años presenta aumento de volumen escrotal, doloroso, de inicio súbito. La conducta más adecuada es:

A) Antibióticos orales
B) Punción escrotal
C) Antiinflamatorios orales
D) Exploración quirúrgica
E) Ecografía escrotal

Respuesta D. Conducta / Tratamiento indicado: Exploración quirúrgica (opción D). Puede se runa torsión testicular, por lo que se debe explorar de inmediato.. La resolución quirúrgica urgente constituye la única medida definitiva capaz de controlar el foco séptico, revertir la isquemia o evitar la muerte materna/fetal frente a este compromiso clínico severo.

4.03.2.008 Trauma urológico

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 11.11 Trauma Abdominal: Cerrado vs Penetrante, Eco-FAST & Laparotomía de Urgencia

QUÉ HAY QUE SABER

- Trauma renal: sospechar con trauma de flanco o desaceleración, equimosis lumbar, fracturas costales bajas o de apófisis transversas y hematuria (macro o microscópica con shock).
- Evaluación ABCDE; el paciente inestable con FAST positivo va a pabellón sin TAC.
- Estable con hematuria: TAC de abdomen y pelvis con contraste y fase excretora (uro-TAC), que clasifica la lesión y muestra extravasación de orina; el pielo-TAC sin contraste no sirve.
- La mayoría de las lesiones renales cerradas se manejan sin cirugía (reposo, hematocrito seriado); angioembolización si hay sangrado activo.
- Trauma vesical/uretral asociado a fractura de pelvis: sangre en el meato, hematoma perineal o próstata alta contraindican la sonda Foley.
- Seguimiento: derivar a urología/cirugía para manejo y control de complicaciones (urinoma, HTA).

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 125

Paciente de 35 años sufre un traumatismo lumbar de alta energía y evoluciona con hematuria. Al examen físico está hemodinámicamente estable, con FC 75 lpm y PA 120/80 mmHg. **¿Cuál es el examen de elección para precisar el diagnóstico?**

A) PieloTAC
B) UroTAC
C) Radiografía de abdomen simple
D) Ecografía renal
E) Pielografía de eliminación

Respuesta B. En el trauma renal con hematuria en un paciente estable, el examen de elección es la TAC con contraste con fase excretora (uroTAC): clasifica la lesión renal, detecta extravasación urinaria y lesiones asociadas. El pieloTAC es sin contraste (para cálculos). La ecografía y la pielografía son poco sensibles. El paciente inestable va a pabellón.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 83 · texto original del banco, sin revisar

Paciente con trauma en región lumbar + hematuria, examen de elección:

A) urotac
B) Eco renal y pélvica
C) Laparotomía exploratoria
D) Cirugía laparoscópica
E) Manejo conservador

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (urotac). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Eco renal y pélvica, Laparotomía exploratoria) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

4.03.2.009 Traumatismo uretral

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 12.5 Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano: Clasificación Tile / Young-Burgess & Estabilización Precoz

QUÉ HAY QUE SABER

- Traumatismo uretral: uretra posterior en fractura de pelvis (sínfisis, 'libro abierto'); uretra anterior/bulbar en caída a horcajadas.
- Signos: sangre en el meato (uretrorragia), imposibilidad de orinar con globo vesical, hematoma perineal en alas de mariposa y próstata ascendida o 'flotante' al tacto rectal.
- Contraindicación absoluta: sonda Foley o Nelaton (puede completar la rotura o crear falsa vía).
- Diagnóstico específico: uretrocistografía retrógrada (contraste por el meato) muestra extravasación.
- Manejo inicial: drenaje vesical con cistostomía suprapúbica por punción (idealmente ecoguiada) o abierta; en la pelvis inestable, estabilizar con sábana pélvica y reponer volumen.
- Seguimiento: derivar a urología para reparación uretral diferida y control de estenosis.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 43

Paciente de 46 años sufre un accidente y presenta una fractura de pelvis. Tiene dolor y salida de sangre fresca por la uretra. Además, se palpa la próstata ascendida en el tacto rectal, y no ha podido orinar. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Pedir un TAC de abdomen y pelvis
B) Solicitar resonancia magnética
C) Realizar cistoscopía
D) Instalar sonda Foley
E) Instalar una cistostomía

Respuesta E. Uretrorragia y próstata ascendida en un paciente con fractura de pelvis son los signos clásicos de una sección uretral. La sonda Foley está formalmente contraindicada; la conducta es la cistostomía suprapúbica, y luego se estudia con uretrografía retrógrada.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 43

Un paciente de 46 años presenta un accidente, resultando con una fractura de pelvis. Presenta dolor y salida de sangre fresca por la uretra. Además se palpa la próstata ascendida en el tacto rectal y no ha podido orinar. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Pedir un TAC de abdomen y pelvis
B) Solicitar resonancia magnética
C) Realizar cistoscopía
D) Instalar sonda Foley
E) Instalar cistostomía

Respuesta E. Es una sección uretral. Está contraindicada la sonda Foley y Nelaton. Se instala cistostomía. Se estudia con uretrocistografía retrógrada y no con los exámenes que ahí aparecían. Se resuelve luego con cirugía.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 61

Un paciente de 24 años sufre un accidente de tránsito a alta velocidad. Ingresa adolorido, con sangre fresca por uretra. Está en buenas condiciones, con estabilidad hemodinámica y sin signos de fracturas en el examen físico. La tomografía axial computada de tórax abdomen y pelvis muestra fractura de pelvis no desplazada, vejiga distendida, sin líquido libre peritoneal. **¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?**

A) Pielografía de eliminación
B) UroTAC
C) Uretrocistografía retrógrada
D) Ecotomografía pélvica
E) Resonancia magnética nuclear de pelvis

Respuesta C. La sospecha es una sección uretral, por lo que se contraindica la sonda Foley, se estudia con uretrocistografía retrógrada, se maneja con cistostomía suprapúbica y, además, con cirugía de reparación uretral.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 90

Un paciente de 42 años sufre un accidente automovilístico, resultado con múltiples traumatismos. Al examen físico tiene movilidad de las extremidades inferiores, sin signos de fractura y examen genital con uretrorragia. Las radiografías confirman una fractura de pelvis estable. **¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?**

A) Pielografía de eliminación endovenosa
B) Uretrocistografía retrógrada
C) Cistoscopía
D) TAC de pelvis
E) Resonancia magnética nuclear de pelvis

Respuesta B. Tiene una sección uretral, la que se estudia con uretrocistografía retrógrada y se trata con cirugía. Recordar que está contraindicada la sonda (también la cistoscopía) y, si hay globo vesical, se maneja con cistostomía suprapúbica.

Conocimientos generales 6 códigos

4.03.3.001 Epidemiología del cáncer de próstata

Dónde se enseña: Tema 13.8 Cáncer de Próstata: Tamizaje APE, Tacto Rectal, Biopsia y Score de Gleason

QUÉ HAY QUE SABER

- Cáncer de próstata: es el cáncer más frecuente en hombres en Chile y una de las primeras causas de muerte oncológica masculina; su incidencia aumenta con la edad.
- Factores de riesgo establecidos: edad (excepcional antes de 45–50 años), familiar de primer grado (duplica o triplica el riesgo; BRCA2) y ascendencia africana. No se ha demostrado relación causal con vasectomía.
- Nace en la zona periférica (~75%), por lo que la enfermedad precoz es asintomática; los síntomas urinarios suelen deberse a HPB coexistente.
- Su diagnóstico se basa en APE, tacto rectal y biopsia; está incluido en GES (biopsia en 30 días, tratamiento en 60 días desde la confirmación).
- Gran parte son tumores de bajo riesgo de lenta evolución: de ahí la vigilancia activa y la preocupación por sobrediagnóstico.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

En una charla de salud del hombre en un CESFAM, se discuten datos epidemiológicos del cáncer de próstata en Chile. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?**

A) Es una neoplasia poco frecuente, principalmente de hombres jóvenes
B) Su incidencia es mayor en hombres asiáticos que en afrodescendientes
C) El tabaquismo es su principal factor de riesgo
D) La vasectomía es un factor de riesgo demostrado
E) Es una de las primeras causas de muerte por cáncer en hombres en Chile, y su incidencia aumenta con la edad; la historia familiar y la ascendencia africana son factores de riesgo

Respuesta E. El cáncer de próstata es el más frecuente en hombres en Chile y una de sus principales causas de muerte oncológica. Sus factores de riesgo establecidos son la edad (raro antes de 50 años), la historia familiar de primer grado (y BRCA2) y la ascendencia africana. No se ha demostrado relación causal con vasectomía ni tabaco.

4.03.3.002 Epidemiología del adenoma de próstata

Dónde se enseña: Tema 13.3 Hiperplasia Prostática Benigna (HPB): IPSS, Tacto Rectal, Tamsulosina/Finasteride & RTUP

QUÉ HAY QUE SABER

- Hiperplasia prostática benigna: prevalencia histológica dependiente de la edad, cerca de 50% a los 60 años y 80–90% a los 80 años.
- Requiere andrógenos testiculares (dihidrotestosterona): no ocurre en castrados prepuberales; base del uso de inhibidores de 5-alfa reductasa.
- Nace en la zona de transición (periuretral), no es premaligna y el tamaño se correlaciona mal con los síntomas.
- Es la causa más frecuente de síntomas urinarios bajos y de retención urinaria aguda en el hombre mayor.
- Complicaciones: retención urinaria, ITU, litiasis vesical, hematuria e insuficiencia renal obstructiva; la cirugía de HPB sintomática tiene garantía GES.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

En una charla para la comunidad, un médico de un CESFAM explica los aspectos epidemiológicos de la hiperplasia prostática benigna a un grupo de hombres adultos. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?**

A) Es una lesión premaligna que evoluciona a cáncer de próstata en la mayoría de los casos
B) Es más frecuente en hombres castrados antes de la pubertad
C) Se origina principalmente en la zona periférica de la próstata
D) Su prevalencia histológica aumenta con la edad, alcanzando alrededor de 50% a los 60 años y cerca de 80 a 90% a los 80 años, y requiere andrógenos testiculares para desarrollarse
E) El tamaño de la próstata se correlaciona estrechamente con la intensidad de los síntomas

Respuesta D. La hiperplasia prostática benigna es muy frecuente y dependiente de la edad y de la dihidrotestosterona: no ocurre en castrados prepuberales. Nace en la zona de transición, no es premaligna, y el tamaño glandular se correlaciona mal con los síntomas. El cáncer, en cambio, nace en la zona periférica.

4.03.3.003 Epidemiologia del cáncer testicular

Dónde se enseña: Tema 13.10 Cáncer de Testículo: Masas Indoloras, Marcadores (AFP, b-hCG, LDH) & Orquiectomía Radical

QUÉ HAY QUE SABER

- Cáncer testicular: tumor sólido más frecuente en hombres de 15 a 35 años (pico 20–35), aunque poco frecuente en términos absolutos.
- Más del 95% son de células germinales: seminoma (50–55%) y no seminoma (embrionario, saco vitelino, coriocarcinoma, teratoma).
- Principal factor de riesgo: criptorquidia (riesgo 4–10 veces; la orquidopexia lo reduce pero no lo elimina); también antecedente personal o familiar y síndrome de Klinefelter.
- Curación >90% incluso con enfermedad avanzada (sensibilidad al cisplatino); garantía GES en personas de 15 años y más.
- Prevención secundaria: examen testicular en controles de adolescentes y adultos jóvenes y orquidopexia precoz de la criptorquidia.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

En una clase de urología, el docente revisa la epidemiología del cáncer testicular para orientar la sospecha clínica en la atención primaria. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?**

A) Más del 90% corresponde a tumores de estroma gonadal, como el de células de Leydig
B) Su incidencia máxima ocurre sobre los 70 años
C) Es el tumor sólido más frecuente en hombres de 15 a 35 años, y la criptorquidia es su principal factor de riesgo
D) La orquidopexia precoz elimina por completo el riesgo de cáncer en el testículo descendido
E) Tiene baja tasa de curación incluso en etapas precoces

Respuesta C. El cáncer testicular es el tumor sólido más frecuente en hombres jóvenes, de 15 a 35 años. Alrededor del 95% son tumores de células germinales. El principal factor de riesgo es la criptorquidia; la orquidopexia reduce pero no elimina el riesgo. Tiene tasas de curación sobre 90% incluso con enfermedad avanzada, y en Chile tiene garantía GES.

4.03.3.004 Factores de riesgo y prevención de ETS

Dónde se enseña: Tema 3.5 Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) II: Uretritis, Úlceras Genitales y VPH

QUÉ HAY QUE SABER

- Factores de riesgo de ITS: inicio sexual precoz, múltiples parejas o pareja nueva, uso inconsistente de preservativo, sexo bajo efecto de alcohol o drogas, sexo transaccional, HSH e ITS previa.
- Medida más eficaz: uso correcto y consistente del preservativo en todas las relaciones; los anticonceptivos hormonales y el DIU no protegen.
- Vacunación: VPH en el Programa Nacional de Inmunizaciones (escolares, niñas y niños de 4.º y 5.º básico) y hepatitis B en el calendario infantil y grupos de riesgo.
- Exposición de riesgo: profilaxis post exposición (PEP) para VIH lo antes posible y antes de 72 h, por 28 días; PrEP en personas con alto riesgo sostenido.
- Testeo periódico de VIH y sífilis (incluida la embarazada), tratamiento de los contactos de los últimos 60 días y búsqueda de otras ITS ante cualquier diagnóstico.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Joven de 19 años consulta para orientación sobre prevención de infecciones de transmisión sexual. Tiene 2 parejas sexuales en el último año y uso inconsistente de preservativo. **¿Cuál es la medida de prevención más efectiva frente a la mayoría de las ITS bacterianas y el VIH en su caso?**
>
> **A)** Vacuna contra VPH, que previene todas las ITS
> **B)** Lavado genital después de cada relación
> **C)** Uso de anticonceptivos orales
> **D)** Uso correcto y consistente del preservativo en todas las relaciones sexuales
> **E)** Antibiótico profiláctico mensual
>
> Respuesta D. El preservativo usado de forma correcta y consistente es la medida de barrera más efectiva contra VIH, gonorrea, clamidia y otras ITS. Se complementa con reducción de parejas, tamizaje periódico (VIH, sífilis), vacunas contra VPH y hepatitis B, y PrEP en personas con alto riesgo. Los anticonceptivos orales y el lavado genital no protegen.

4.03.3.005 Screening de cáncer de próstata

Dónde se enseña: Tema 13.8 Cáncer de Próstata: Tamizaje APE, Tacto Rectal, Biopsia y Score de Gleason

QUÉ HAY QUE SABER

- En Chile no existe un programa de tamizaje poblacional de cáncer de próstata: la detección con APE es oportunista, con decisión informada sobre beneficios y riesgos (sobrediagnóstico, biopsias).
- Población objetivo de la detección: hombres de 50 a 70 años (desde los 45 si hay familiar de primer grado o ascendencia africana); no se tamiza a mayores de 70–75 años ni con expectativa de vida <10 años.
- Se usa APE junto con tacto rectal; corte clásico 4 ng/mL; un APE alterado se repite a las 4–6 semanas descartando ITU, prostatitis o sondeo reciente.
- Con inhibidores de 5-alfa reductasa (finasteride, dutasteride) por más de 6 meses, multiplicar el APE por 2.
- Nódulo pétreo o APE confirmado sobre 4: derivar a urología para biopsia, con garantía GES (30 días desde la sospecha).

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Hombre de 63 años, asintomático, en chequeo de salud. El tacto rectal muestra una próstata algo aumentada con un nódulo indurado, pétreo, de 1 cm en el lóbulo derecho. Trae un APE total de 2,2 ng/mL y se siente aliviado. **¿Cuál es la conducta?**
>
> **A)** Control con APE en 1 año, porque es normal
> **B)** Biopsia prostática transrectal ecoguiada
> **C)** Antibióticos por 4 semanas por prostatitis
> **D)** Solicitar APE libre sobre total para decidir
> **E)** Iniciar finasteride y repetir el APE
>
> Respuesta B. Un nódulo pétreo es indicación de biopsia aunque el APE sea normal, porque entre 15 y 25% de los cánceres relevantes tienen APE bajo 4. Se deriva a urología para biopsia con garantía GES.

4.03.3.006 Trasplante renal, indicaciones y complicaciones

Dónde se enseña: Tema 5.1 Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)

QUÉ HAY QUE SABER

- Trasplante renal: mejor terapia de reemplazo en ERC etapa 5 (mejor sobrevida y calidad de vida que diálisis); está cubierto por GES junto con la diálisis.
- Se evalúa a pacientes en etapa 4–5 sin contraindicación (cáncer activo, infección activa, enfermedad cardiovascular grave no tratable, mala adherencia); donante vivo o cadáver.
- Inmunosupresión habitual: inhibidor de calcineurina (tacrolimus), micofenolato y prednisona; nefrotoxicidad por tacrolimus requiere control de niveles.
- Complicaciones: rechazo (agudo con alza de creatinina, crónico lento), infecciones según tiempo (1–6 meses oportunistas: CMV, Pneumocystis; profilaxis con cotrimoxazol ≥6 meses), pielonefritis del injerto, neoplasias (piel, linfoma) y riesgo cardiovascular.
- El médico general debe reconocer fiebre, dolor sobre el injerto o alza de creatinina y derivar precozmente; revisar interacciones con inhibidores o inductores del CYP3A4.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Mujer de 45 años, trasplantada renal hace 4 meses, en tratamiento con tacrolimus, micofenolato y prednisona. Consulta por fiebre de 38 °C, tos y disnea progresiva de 1 semana. Radiografía con infiltrado intersticial bilateral. LDH elevada. Suspendió por su cuenta la profilaxis con cotrimoxazol hace 1 mes. **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**
>
> **A)** Pneumocystis jirovecii
> **B)** Streptococcus pneumoniae
> **C)** Mycoplasma pneumoniae
> **D)** Legionella pneumophila
> **E)** Rechazo agudo del injerto
>
> Respuesta A. Entre el primer y sexto mes postrasplante predominan las infecciones oportunistas (CMV, Pneumocystis), por la inmunosupresión máxima. Neumonía intersticial bilateral con LDH alta e hipoxemia, sin profilaxis con cotrimoxazol, sugiere Pneumocystis jirovecii. Se trata con cotrimoxazol en dosis altas. Por eso la profilaxis se mantiene al menos 6 meses.

Exámenes e imagenología 13 códigos

4.03.4.001 Radiografía renal y vesical simple

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 13.1 Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea

QUÉ HAY QUE SABER

- Radiografía renal y vesical simple (abdomen RUV): ve cálculos radiopacos, que son cerca del 90% (oxalato y fosfato de calcio, estruvita); la cistina es débilmente opaca.
- Los cálculos de ácido úrico son radiolúcidos: no se ven en la radiografía pero sí en el TAC; asociados a gota y orina ácida.
- Indicación principal: seguimiento de la expulsión de un cálculo radiopaco ya visto, con menos radiación que repetir TAC; no es el examen diagnóstico del cólico (es el pielo-TAC).
- Hallazgos a interpretar: calcificaciones en la proyección renal o ureteral, cálculo coraliforme y nefrocalcinosis; diferenciar de flebolitos pélvicos y calcificaciones vasculares.
- Limitaciones: gas intestinal, superposición ósea y poca sensibilidad para cálculos pequeños.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 40 años con cólico renal derecho. La TAC sin contraste muestra un cálculo de 6 mm en el uréter distal derecho, de densidad alta. Se decide manejo médico expulsivo y seguimiento. **¿Cuál es el examen más adecuado para el seguimiento de la expulsión de este cálculo?**

A) Radiografía simple renal, ureteral y vesical (de abdomen), ya que la mayoría de los cálculos son radiopacos
B) Pielografía de eliminación semanal
C) Resonancia magnética de abdomen
D) Cintigrama renal
E) Cistoscopía

Respuesta A. Cerca del 90% de los cálculos urinarios (oxalato y fosfato de calcio) son radiopacos, por lo que la radiografía simple de abdomen (riñón, uréter y vejiga) sirve para el seguimiento de un cálculo visible, con menor radiación que repetir TAC. Los de ácido úrico son radiolúcidos y no se ven en la radiografía.

4.03.4.002 Pielografía de eliminación

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 13.1 Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea

QUÉ HAY QUE SABER

- Pielografía de eliminación (urografía excretora): radiografías seriadas tras contraste yodado EV; muestra función y anatomía de cálices, pelvis y uréteres.
- Hoy está en gran medida reemplazada por el uro-TAC (para hematuria) y el pielo-TAC (para cólico renal).
- Hallazgos del informe: retardo de eliminación y dilatación en obstrucción, defectos de llenado (tumor urotelial, cálculo radiolúcido, coágulo), duplicidad o malformaciones.
- Contraindicaciones: insuficiencia renal (VFG <30 mL/min, mala imagen y nefropatía por contraste), alergia grave al contraste y embarazo; precaución con metformina.
- Ante un cólico renal no se pide: el examen de elección es el pielo-TAC sin contraste.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Se evalúa a un paciente para un estudio de la vía urinaria con medio de contraste yodado endovenoso (pielografía de eliminación o uroTAC). **¿Cuál de las siguientes condiciones es la principal limitación o contraindicación relativa para este estudio?**

A) Hipertensión arterial controlada
B) Infección urinaria baja tratada
C) Litiasis renal
D) Hematuria macroscópica
E) Insuficiencia renal con VFG menor de 30 mL/min o antecedente de reacción alérgica grave al medio de contraste

Respuesta E. La pielografía de eliminación (urografía excretora) depende de la excreción renal de contraste yodado, por lo que en insuficiencia renal la imagen es pobre y hay riesgo de nefropatía por contraste; la alergia grave al contraste también la contraindica. Hoy ha sido reemplazada en gran medida por el uroTAC, que comparte estas limitaciones.

4.03.4.003 Pielo TAC

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 13.1 Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea

QUÉ HAY QUE SABER

- Pielo-TAC: TAC de abdomen y pelvis sin contraste; examen de elección en el cólico renal, con sensibilidad y especificidad >95%.
- Ve cálculos de cualquier composición (incluido ácido úrico), su tamaño, ubicación y dureza (UH), la hidronefrosis y diagnósticos diferenciales (apendicitis, diverticulitis, aneurisma).
- El tamaño informado guía la conducta: <5 mm observar, 5–10 mm tamsulosina, >10 mm derivar; ubicación y dureza orientan a LEOC o ureteroscopía.
- No confundir con uro-TAC (con contraste y fase excretora), que se usa para estudiar hematuria y tumores uroteliales.
- En embarazadas y niños se prefiere la ecografía; en el seguimiento de cálculos radiopacos puede bastar la radiografía simple.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 50

Un paciente presenta dolor lumbar intenso irradiado al testículo, asociado a vómitos e inquietud psicomotora. Su sedimento de orina muestra microhematuria. **¿Qué examen es el más adecuado para confirmar el diagnóstico en este paciente?**

A) TAC de abdomen con contraste
B) Ecografía abdominal
C) PieloTAC
D) Pielografía de eliminación
E) Radiografía simple de abdomen y pelvis

Respuesta C. Ante un cólico renal típico, el examen de elección es el pieloTAC, una tomografía sin contraste que detecta cálculos de cualquier composición y localización, con sensibilidad y especificidad cercanas a 97%. La ecografía es alternativa en embarazadas y niños, pero ve mal el uréter.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 90 · texto original del banco, sin revisar

Hombre de 45 años con dolor lumbar derecho irradiado a la región inguinal, tipo cólico, de inicio súbito. Uroanálisis: microhematuria, sin piuria. Urocultivo pendiente. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?

A) Ecografía renal y de vías urinarias
B) Resonancia magnética
C) UroTAC (PieloTAC sin contraste)
D) Radiografía simple de abdomen
E) Cintigrafía renal

Respuesta C. Cólico renal (ureterolitiasis): UroTAC sin contraste es el gold standard diagnóstico (sensibilidad 97%, especificidad 96%). Detecta cálculos de cualquier composición, localización y tamaño. La ecografía renal es alternativa inicial (menos sensible para uréteres).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 129 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 18 años, sin antecedentes, consulta por dolor en flanco izquierdo de 1 hora de evolución tipo cólico e irradiado a genitales, sin otros síntomas. Su examen físico es normal. Se solicita sedimento de orina muestra 50 eritrocitos por campo, sin dismorfia. El examen de elección para el diagnóstico en este caso es:

A) Tomografía axial computada con contraste
B) Pielografía de eliminación
C) Radiografía de abdomen
D) Ecografía abdominal
E) Tomografía axial computada sin contraste

Respuesta E. Diagnóstico: Tomografía axial computada sin contraste (opción E). El pieloTAC no tiene contraste y es el examen de elección para el cólico renal. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

4.03.4.004 TAC de abdomen y pelvis

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 13.11 Cáncer Renal: Carcinoma de Células Claras, Tríada Clásica, TAC y Nefrectomía

QUÉ HAY QUE SABER

- TAC de abdomen y pelvis con contraste: examen de elección para caracterizar masas renales (TAC trifásico: realce >15–20 UH sugiere carcinoma) y quistes complejos (Bosniak).
- Con fase excretora (uro-TAC): estudio de hematuria con riesgo oncológico y del urotelio superior, y del trauma renal en paciente estable (extravasación de orina).
- Otras indicaciones: pielonefritis que no responde a 48–72 h (absceso renal o perirrenal), etapificación de cánceres urológicos y búsqueda de tumor en varicocele derecho o que no colapsa.
- Contraindicaciones relativas: VFG <30 mL/min, alergia al contraste y embarazo; para el cólico renal se usa sin contraste (pielo-TAC).
- El paciente traumatizado inestable no va al TAC: va a pabellón.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 50

Paciente de 30 años sufre una caída de altura, con traumatismo contuso en el flanco derecho, asociado a hematuria macroscópica. Al examen físico presenta equimosis en el flanco derecho, sin otros hallazgos. **¿Cuál de los siguientes exámenes es el más indicado para el estudio de este paciente?**

A) Ecografía abdominal
B) Tomografía axial computada sin contraste de abdomen
C) Radiografía abdominal
D) Tomografía axial computada con contraste de abdomen
E) Pielografía de eliminación

Respuesta D. Un traumatismo de flanco con hematuria macroscópica en un paciente estable se estudia con TAC de abdomen y pelvis con contraste endovenoso y fase excretora, que clasifica la lesión renal, muestra extravasación de orina y lesiones asociadas. El pieloTAC sin contraste es para la litiasis.

4.03.4.005 Uretrocistografía

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 13.2 Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía

QUÉ HAY QUE SABER

- Uretrocistografía retrógrada: contraste instilado por el meato; examen de elección ante sospecha de trauma uretral (sangre en el meato, fractura de pelvis, caída a horcajadas) y para estenosis de uretra anterior.
- Hallazgos: extravasación de contraste (rotura uretral) o estrechez con su ubicación y longitud (estenosis).
- Uretrocistografía miccional: se llena la vejiga y se obtienen imágenes al orinar; diagnostica y gradúa el reflujo vesicoureteral (I a V) y las valvas uretrales posteriores (uretra posterior dilatada).
- La miccional se pide en niños con ecografía alterada o ITU febril atípica o recurrente, fuera de la fase aguda y con urocultivo negativo.
- Ante sospecha de lesión uretral no se sonda antes del estudio; si hay globo vesical se drena con cistostomía.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 142

Paciente con antecedente de resección transuretral de próstata hace 10 años, sin micción desde hace 8 horas. Al intentar instalar una sonda, esta no avanza más allá de la uretra bulbar y se produce uretrorragia. No hay globo vesical palpable. **¿Cuál es el examen de elección?**

A) Ecografía pelviana
B) UroTAC sin contraste
C) Uretrografía retrógrada
D) Cistouretrografía miccional
E) Cistoscopía flexible

Respuesta C. Una sonda que no progresa en la uretra bulbar en un paciente con instrumentación previa sugiere estenosis uretral. La uretrografía retrógrada (contraste por el meato) define ubicación y longitud de la estenosis anterior. La cistouretrografía miccional requiere que el paciente orine o vejiga accesible, y evalúa mejor la uretra posterior y el reflujo.

4.03.4.006 Ecografía renal (tamaño, asimetrías, hidronefrosis)

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 1.1 Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca

QUÉ HAY QUE SABER

- Ecografía renal: examen inicial, inocuo y sin contraste para evaluar tamaño renal, asimetrías, hidronefrosis, quistes, masas y litiasis.
- Ante injuria renal aguda, el primer paso es descartar obstrucción: hidronefrosis bilateral o globo vesical indica causa postrenal tratable.
- Riñones pequeños (<9 cm), con corteza adelgazada e hiperecogénicos indican ERC avanzada; excepciones con riñones grandes: diabetes, poliquistosis, amiloidosis y VIH.
- Asimetría >1,5 cm sugiere enfermedad renovascular; riñones grandes con múltiples quistes bilaterales, poliquistosis.
- Quiste simple (anecogénico, pared fina, refuerzo posterior): alta; quiste complejo o masa sólida: TAC con contraste. En niños, a todos tras la primera ITU febril.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Hombre de 75 años con creatinina de 3,2 mg/dL (basal desconocida), sin síntomas urinarios claros. Se solicita ecografía renal. **¿Qué hallazgo ecográfico orienta más a enfermedad renal crónica que a injuria renal aguda?**
>
> **A)** Riñones de tamaño normal con hidronefrosis bilateral
> **B)** Riñones aumentados de tamaño
> **C)** Riñones pequeños (menores de 9 cm), con corteza adelgazada y aumento de la ecogenicidad
> **D)** Asimetría renal mayor de 1,5 cm por uno grande
> **E)** Vejiga distendida
>
> Respuesta C. La ecografía renal permite distinguir cronicidad: riñones pequeños, de corteza delgada e hiperecogénicos indican ERC avanzada. Además descarta obstrucción (hidronefrosis), la principal causa reversible, y detecta asimetrías (mayor de 1,5 cm sugiere enfermedad renovascular). Excepciones de ERC con riñones grandes: diabetes, poliquistosis, amiloidosis y VIH.

4.03.4.007 Ecotomografía de vejiga y próstata

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 13.3 Hiperplasia Prostática Benigna (HPB): IPSS, Tacto Rectal, Tamsulosina/Finasteride & RTUP

QUÉ HAY QUE SABER

- Ecotomografía vésico-prostática (suprapúbica): estima el volumen prostático y mide el residuo postmiccional; residuo >100–150 mL indica vaciamiento incompleto y riesgo de retención.
- Muestra repercusión vesical de la obstrucción: vejiga de lucha (pared engrosada, trabeculada), divertículos y litiasis vesical; complementar con ecografía renal para hidronefrosis.
- El volumen orienta el tratamiento de la HPB: >40 cc agregar inhibidor de 5-alfa reductasa; <80 cc RTUP, >80 cc adenomectomía o láser.
- No diagnostica cáncer de próstata (requiere APE, tacto y biopsia transrectal ecoguiada), ni mide flujo ni presiones.
- Útil también en incontinencia (residuo >200 mL confirma rebalse) y en masas vesicales.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Hombre de 68 años con síntomas urinarios bajos obstructivos moderados (IPSS 18), tacto rectal con próstata aumentada de tamaño, lisa, elástica y sin nódulos. Creatinina normal. **¿Qué información principal aporta la ecotomografía vesical y prostática en este paciente?**
>
> **A)** Diagnóstico histológico de cáncer de próstata
> **B)** Volumen prostático, residuo postmiccional y repercusión vesical (engrosamiento de pared, divertículos, cálculos)
> **C)** Medición del flujo urinario máximo
> **D)** Presión del detrusor durante la micción
> **E)** Etapificación ganglionar
>
> Respuesta B. En la HPB, la ecografía vesicoprostática (suprapúbica) mide el volumen prostático, el residuo postmiccional y muestra repercusión vesical (vejiga de lucha, divertículos, litiasis); la ecografía renal descarta hidronefrosis. No diagnostica cáncer (requiere APE y biopsia) ni mide flujo (uroflujometría) ni presiones (urodinamia).

4.03.4.008 Ecotomografía testicular

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 13.5 Torsión Testicular vs Torsión de Hidátide: Doppler Testicular & Exploración Quirúrgica <6h · Tema 13.10 Cáncer de Testículo: Masas Indoloras, Marcadores (AFP, b-hCG, LDH) & Orquiectomía Radical

QUÉ HAY QUE SABER

- Ecografía testicular con Doppler: primer examen ante toda masa escrotal; distingue lesión intratesticular sólida (sospechosa de cáncer, sensibilidad cercana al 100%) de lesiones extratesticulares benignas.
- Tumor: nódulo intratesticular hipoecogénico, heterogéneo y con flujo aumentado; se complementa con AFP, beta-hCG y LDH y se deriva para orquiectomía inguinal.
- Escroto agudo: ausencia de flujo intratesticular y signo del remolino sugieren torsión; flujo aumentado en epidídimo, epididimitis; nódulo avascular en polo superior con flujo conservado, torsión de hidátide.
- En la torsión con sospecha clínica alta no se espera la ecografía: exploración quirúrgica inmediata.

- Otros hallazgos: hidrocele (líquido que rodea el testículo, obligatorio descartar tumor en adulto), quiste de epidídimo y varicocele (venas >3 mm con reflujo en Valsalva).

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Escolar de 11 años consulta por dolor testicular derecho de 20 horas, de inicio gradual, moderado, sin vómitos. Afebril. El testículo derecho está en posición normal, levemente sensible en su polo superior, con reflejo cremastérico presente. El cuadro es dudoso, por lo que se solicita ecografía Doppler testicular inmediata. **Si la ecografía Doppler muestra flujo arterial intratesticular conservado y simétrico, con una imagen nodular avascular en el polo superior, ¿cuál es la interpretación y conducta más adecuada?**

A) Torsión testicular; exploración quirúrgica inmediata
B) Hidrocele a tensión; punción evacuadora
C) Tumor testicular; orquiectomía inguinal
D) Orquiepididimitis bacteriana; ceftriaxona más doxiciclina
E) Torsión de hidátide (apéndice testicular); reposo, AINE, frío local y control

Respuesta E. La ecografía Doppler testicular es útil cuando el escroto agudo es dudoso: flujo intratesticular conservado descarta razonablemente la torsión, y un nódulo avascular en el polo superior es típico de la torsión de hidátide, que se trata en forma conservadora. Si la clínica es clara de torsión, no se debe retrasar la cirugía por la ecografía.

Pregunta de práctica

Hombre de 28 años nota hace 3 semanas un nódulo en el testículo izquierdo, levemente molesto. Al examen se palpa un nódulo duro de 1,5 cm que parece depender del testículo, no transilumina, sin signos inflamatorios. Afebril y sin síntomas urinarios. **¿Cuál es el examen inicial más adecuado?**

A) Biopsia testicular por punción transescrotal
B) Ecografía testicular con Doppler
C) TAC de tórax, abdomen y pelvis
D) Tratamiento antibiótico por 2 semanas y luego reevaluar
E) Resonancia magnética de pelvis

Respuesta B. Ante toda masa escrotal, el examen inicial es la ecografía testicular: distingue lesión intratesticular sólida, sospechosa de cáncer, de lesiones extratesticulares benignas como quistes del epidídimo o hidrocele, con sensibilidad cercana a 100%. La punción transescrotal está contraindicada por riesgo de diseminación.

4.03.4.009 Cintigrama renal

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 18.13 Infección del Tracto Urinario (ITU) en Pediatría: ITU Febril, Estudio por Imágenes & Profilaxis

QUÉ HAY QUE SABER

- Cintigrama renal estático con DMSA: examen de elección para detectar cicatrices renales (daño parenquimatoso) tras pielonefritis, realizado 4–6 meses después del episodio.
- En la fase aguda puede mostrar defectos inflamatorios reversibles que no son cicatriz; por eso se difiere.
- También informa la función renal diferencial (cada riñón aporta normalmente 45–55%).
- Cintigrama dinámico (MAG3 o DTPA con diurético): evalúa obstrucción (curva de eliminación) y función diferencial en hidronefrosis y estenosis pieloureteral; función ≤10% sugiere riñón no recuperable.
- No evalúa reflujo: para eso se usa la uretrocistografía miccional.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Niña de 2 años que tuvo una pielonefritis aguda febril hace 5 meses, tratada adecuadamente. Su ecografía renal fue normal. Se desea evaluar si quedaron cicatrices en el parénquima renal. **¿Cuál es el examen de elección?**

A) TAC de abdomen sin contraste
B) Cintigrama renal con MAG3 y diurético
C) Uretrocistografía miccional
D) Urocultivo de control
E) Cintigrama renal con DMSA (ácido dimercaptosuccínico)

Respuesta E. El cintigrama estático con DMSA es el estándar para detectar cicatrices renales; se realiza 4 a 6 meses después de la pielonefritis para no confundir inflamación aguda con cicatriz. El cintigrama dinámico (MAG3 o DTPA con diurético) evalúa obstrucción y función diferencial con curva de eliminación. La uretrocistografía evalúa reflujo, no cicatrices.

4.03.4.010 Antígeno prostático específico

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 13.8 Cáncer de Próstata: Tamizaje APE, Tacto Rectal, Biopsia y Score de Gleason

QUÉ HAY QUE SABER

- Antígeno prostático específico (APE): proteasa órgano-específica, no cáncer-específica; sube en cáncer, HPB, prostatitis, ITU, sondeo, biopsia y eyaculación reciente.
- Corte clásico 4 ng/mL; >10 alto riesgo. Un valor alterado se repite a las 4–6 semanas tras descartar o tratar infección.
- Afinan la zona gris (4–10): relación libre/total <15% sugiere cáncer; densidad >0,15 y velocidad >0,75 ng/mL/año también.
- Finasteride o dutasteride por >6 meses lo reducen a la mitad: multiplicar por 2; la tamsulosina no lo modifica.
- Un APE normal no descarta cáncer: un nódulo pétreo al tacto obliga a biopsia; tras tratamiento se usa para detectar recidiva.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 61 años, asintomático. Tacto rectal normal. APE total de 6,2 ng/mL; descartada una infección urinaria, se repite a las 4 semanas: 6,4 ng/mL, con relación APE libre/total de 9%. **¿Cuál es la conducta diagnóstica más adecuada?**

A) Tamsulosina y control con APE en 1 año
B) Biopsia prostática guiada por ecografía transrectal
C) Cintigrama óseo de entrada
D) Finasteride por 6 meses para ver si el APE baja
E) Tranquilizar porque no hay nódulo

Respuesta B. APE confirmado en la zona gris con fracción libre de 9%, menor de 15%: alto riesgo de cáncer. Corresponde biopsia. El finasteride enmascararía el APE y retrasaría el diagnóstico.

4.03.4.011 Examen de orina completo, urocultivo

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 13.15 Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas

QUÉ HAY QUE SABER

- Orina completa: hematuria ≥3 GR/campo; GR dismórficos, acantocitos y cilindros hemáticos indican origen glomerular; coágulos indican origen urológico. Cilindros leucocitarios: origen renal (pielonefritis, nefritis intersticial).
- Nitritos positivos son específicos de enterobacterias, pero un nitrito negativo no descarta ITU (requiere ~4 h de orina en vejiga; Enterococcus y S. saprophyticus no los producen).
- Urocultivo: segundo chorro ≥100.000 UFC/mL; en mujer con cistitis y piuria, desde 1.000–10.000 UFC/mL de un uropatógeno es significativo. Niños: cateterismo ≥10.000, punción suprapúbica cualquier recuento; bolsa recolectora solo sirve si es negativa.
- Piuria estéril (leucocituria con urocultivo negativo): pensar en TBC urinaria, uretritis por Chlamydia, nefritis intersticial o tratamiento antibiótico previo.

- Bacteriuria asintomática no se trata salvo en embarazo o antes de cirugía urológica con sangrado de mucosa; tomar siempre urocultivo antes de antibiótico en pielonefritis.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 28 años, no embarazada, consulta por disuria, polaquiuria y urgencia miccional de 2 días, sin fiebre ni dolor lumbar. Se toma orina de segundo chorro con aseo genital previo. Orina completa: nitritos positivos, leucocitos 25 a 30 por campo, bacterias abundantes. El urocultivo informa Escherichia coli 10.000 UFC/mL sensible a nitrofurantoína. **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**

A) Urocultivo negativo porque no alcanza 100.000 UFC/mL; no corresponde tratar
B) Contaminación de la muestra; repetir con punción suprapúbica
C) Infección urinaria baja; en una mujer sintomática con piuria, un recuento desde 1.000 a 10.000 UFC/mL de un uropatógeno es significativo y se trata, por ejemplo con nitrofurantoína
D) Bacteriuria asintomática; no requiere tratamiento
E) Pielonefritis aguda; hospitalizar para antibióticos endovenosos

Respuesta C. El punto de corte de 100.000 UFC/mL se diseñó para bacteriuria asintomática. En una mujer con síntomas de cistitis y piuria, recuentos menores (desde 1.000 a 10.000 UFC/mL) de un uropatógeno como E. coli son significativos. Los nitritos positivos y la piuria apoyan el diagnóstico de cistitis, que se trata ambulatoriamente.

4.03.4.012 Urodinamia

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 13.4 Incontinencia Urinaria en el Adulto: Esfuerzo vs Urgencia vs Rebose & Vejiga Neurogénica

QUÉ HAY QUE SABER

- Urodinamia (cistometría y estudio flujo-presión): mide presiones vesical y abdominal durante el llenado y el vaciamiento.
- Indicaciones: incontinencia mixta o refractaria, antes de cirugía antiincontinencia, vejiga neurogénica, síntomas que no calzan con la clínica o falla de tratamiento.
- Distingue hiperactividad del detrusor (contracciones involuntarias en el llenado) de incompetencia esfinteriana, y obstrucción infravesical de hipocontractilidad del detrusor.
- No es necesaria en la incontinencia de esfuerzo pura no complicada antes del tratamiento conservador.
- Su informe evita cirugías que empeoren la urgencia o provoquen retención.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 55 años con incontinencia urinaria mixta (esfuerzo y urgencia) que no mejoró con ejercicios de piso pélvico ni con antimuscarínicos. Se plantea cirugía antiincontinencia. **¿Cuál es la principal utilidad del estudio urodinámico en esta paciente?**

A) Confirmar infección urinaria
B) Objetivar el tipo de incontinencia (hiperactividad del detrusor vs incompetencia esfinteriana) y la función de vaciamiento antes de la cirugía
C) Medir el volumen de la vejiga en reposo por ecografía
D) Diagnosticar cáncer vesical
E) Reemplazar el examen físico ginecológico

Respuesta B. La urodinamia (cistometría, estudio de flujo-presión) mide presiones vesicales y abdominales durante llenado y vaciamiento. No es necesaria en la incontinencia de esfuerzo pura no complicada, pero sí en la incontinencia mixta, refractaria o antes de cirugía, para documentar hiperactividad del detrusor o incompetencia esfinteriana y evitar cirugías que empeoren la urgencia o produzcan retención.

4.03.4.013 Uroflujometría

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 13.3 Hiperplasia Prostática Benigna (HPB): IPSS, Tacto Rectal, Tamsulosina/Finasteride & RTUP

QUÉ HAY QUE SABER

- Uroflujometría: mide el flujo urinario durante una micción espontánea; válida con volumen miccional >150 mL.
- Normal: Qmáx >15 mL/s con curva en campana; Qmáx <10 mL/s con curva aplanada y prolongada sugiere obstrucción (HPB, estenosis uretral) o hipocontractilidad del detrusor.

- Curva en meseta (plateau) es típica de estenosis uretral; para diferenciar obstrucción de detrusor débil se requiere estudio flujo-presión.
- Se complementa con residuo postmiccional por ecografía.
- Usos: evaluación inicial y seguimiento de síntomas urinarios bajos en el hombre, control post RTUP o uretrotomía.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 65 años con chorro débil y sensación de vaciamiento incompleto. Se realiza uroflujometría con volumen miccional de 250 mL. **¿Qué resultado sugiere obstrucción del tracto urinario inferior?**

A) Flujo máximo (Qmáx) mayor de 15 mL/s con curva en campana
B) Volumen miccional de 250 mL
C) Flujo máximo menor de 10 mL/s con curva aplanada y prolongada
D) Residuo postmiccional de 10 mL
E) Tiempo miccional de 15 segundos

Respuesta C. La uroflujometría mide el flujo urinario; es válida con volumen miccional mayor de 150 mL. Un Qmáx menor de 10 mL/s con curva aplanada y prolongada sugiere obstrucción (HPB, estenosis uretral) o hipocontractilidad del detrusor; mayor de 15 mL/s es normal. Para diferenciarlas se requiere estudio de flujo-presión.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos 6 códigos

4.03.5.001 Biopsia prostática

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 13.8 Cáncer de Próstata: Tamizaje APE, Tacto Rectal, Biopsia y Score de Gleason

QUÉ HAY QUE SABER

- Biopsia prostática: transrectal (o transperineal) guiada por ecografía, idealmente con fusión con resonancia; 10–12 cilindros; único método que confirma el cáncer de próstata.
- Indicaciones: nódulo pétreo o asimetría al tacto rectal (aunque el APE sea normal) o APE >4 ng/mL confirmado, con relación libre/total baja o RM sospechosa.
- El médico general deriva a urología con garantía GES: biopsia dentro de 30 días desde la sospecha fundada.
- Requiere profilaxis antibiótica (transrectal) y suspender anticoagulantes/antiagregantes según indicación; complicaciones: hematuria, hemospermia, rectorragia, retención y prostatitis/sepsis.
- Resultado: Gleason/ISUP (3+3 ISUP 1 bajo riesgo; 4+3 ISUP 3 peor que 3+4) que define riesgo y tratamiento.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 78

Un paciente de 60 años, que durante una infección urinaria, se detectó APE de 14,2 ng/ml y un tacto rectal, con presencia de un nódulo prostático duro. Una vez tratada con éxito su infección, el APE bajó a 12 ng/ml. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Prostatectomía radical
B) Seguimiento con APE y tacto en 1 año
C) Ecografía de próstata
D) Resección transuretral
E) Biopsia prostática

Respuesta E. Tanto por el nódulo como por el APE mayor a 4, está indicada la biopsia.

4.03.5.002 Cistoscopia

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 13.12 Cáncer de Vejiga: Hematuria Macroscópica Silente, Cistoscopía & RTUV

QUÉ HAY QUE SABER

- Cistoscopía: visualización endoscópica directa de uretra y vejiga; examen que confirma el cáncer vesical y permite biopsia.
- Indicación principal: hematuria macroscópica o microscópica urológica en paciente con riesgo (>50 años, fumador, aminas aromáticas), junto con uro-TAC; la citología no la reemplaza.

- Otras: síntomas irritativos refractarios (carcinoma in situ), seguimiento de cáncer vesical, instalación de catéter doble J, estudio de estenosis y fístulas.
- Contraindicada en sospecha de trauma uretral y relativamente en ITU activa (tomar urocultivo antes).
- El médico general deriva a urología; no reemplaza el estudio de la vía urinaria superior.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 45

Un paciente de 68 años, fumador de 20 paquetes-año, presenta hematuria abundante, con coágulos. Se realiza un sedimento que muestra incontables glóbulos rojos y un urocultivo que resulta negativo. Se le realiza un TAC de abdomen y pelvis que no muestra alteraciones. ¿Qué examen es el más adecuado para proseguir con el estudio en este paciente?
¿Qué examen es el más adecuado para proseguir el estudio?

A) Ecografía pélvica
B) Resonancia magnética nuclear
C) Pielografía de eliminación
D) Cistoscopía
E) Uretrocistografía

Respuesta D. Probable cáncer de vejiga. El TAC ya descartó causa renal, y falta ver la mucosa de la vejiga con cistoscopía.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 85 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 54 años consulta por un cuadro de 6 meses de evolución de disuria, polaquiuria y dolor abdominal bajo. Sus urocultivos repetidos han resultado negativos. Al examen físico tiene mucosa vaginal seca y pálida. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar terapia de reemplazo hormonal oral
B) Solicitar cistoscopía
C) Solicitar ecografía transvaginal
D) Indicar estrógenos tópicos
E) Iniciar antimicóticos orales

Respuesta B. Es una pregunta discutible, ya que tiene la historia de una cistitis intersticial (se estudia con cistoscopía) y también la de atrofia genital (se trataría con estrógenos tópicos). El dolor abdominal bajo y la polaquiuria sugieren mucho más una cistitis intersticial.

4.03.5.003 Cistostomía abierta

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 13.2 Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía

QUÉ HAY QUE SABER

- Cistostomía abierta (quirúrgica): drenaje vesical suprapúbico mediante incisión, en pabellón.
- Indicaciones: drenaje vesical cuando la cistostomía por punción no es segura o es imposible (vejiga no palpable o no distendida, cirugía pélvica previa, obesidad, coagulopatía) o en trauma uretral que requiere exploración vesical.
- En trauma uretral con globo vesical palpable, la opción inicial es la punción (ecoguiada); la abierta se reserva a los casos anteriores.
- El médico general estabiliza, no sonda la uretra con sospecha de lesión y deriva a urología/cirugía.
- Cuidados posteriores: fijación del catéter, cambios periódicos y vigilancia de infección del trayecto.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 30 años, tras caída a horcajadas sobre una viga, presenta sangre en el meato uretral, hematoma perineal en alas de mariposa y no puede orinar. Tiene globo vesical palpable. Está estable. **¿Cuál es la conducta más adecuada para drenar la vejiga?**

A) Instalar sonda Foley por vía uretral con fuerza
B) Sondeo con sonda metálica
C) Esperar micción espontánea
D) Cistostomía suprapúbica (por punción o abierta) y luego estudio con uretrografía retrógrada
E) Uretroplastía inmediata

Respuesta D. Uretrorragia, hematoma perineal y retención tras trauma a horcajadas indican lesión de uretra bulbar. Está contraindicado el sondeo uretral a ciegas porque puede completar la rotura. La vejiga se drena con cistostomía suprapúbica (percutánea o abierta si la vejiga no es puncionable con seguridad), y se estudia con uretrografía retrógrada; la reparación es diferida.

4.03.5.004 Cistostomía por punción

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 13.2 Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía

QUÉ HAY QUE SABER

- Cistostomía por punción (Cystofix): drenaje vesical suprapúbico percutáneo con trocar de 10–14 Fr, idealmente guiado por ecografía.
- Indicaciones: retención urinaria con trauma uretral (uretrorragia, hematoma perineal, fractura de pelvis), sonda Foley imposible (estenosis, falsa vía) y prostatitis aguda.
- Requisito: globo vesical palpable o vejiga distendida confirmada; contraindicada sin globo, con cirugía o cáncer vesical/pélvico, coagulopatía o infección de la pared.
- Técnica: punción en línea media 2 traveses de dedo sobre el pubis, perpendicular o levemente caudal, aséptica con anestesia local; confirmar orina y fijar.
- Complicaciones: punción intestinal, hematoma de pared y hematuria; luego estudiar la uretra con uretrografía retrógrada y derivar a urología.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 25 años sufre una caída a horcajadas sobre una viga. Consulta por imposibilidad de orinar de 6 horas. Al examen hay sangre en el meato uretral, hematoma perineal en alas de mariposa y globo vesical palpable a 3 cm bajo el ombligo. Hemodinámicamente estable. **¿Cuál es la conducta más adecuada para drenar la vejiga?**

A) Sonda Foley transuretral con lubricación abundante
B) Punción vesical con aguja y aspiración repetida cada 6 horas
C) Sondeo con sonda metálica para vencer la estrechez
D) Furosemida endovenosa y esperar micción espontánea
E) Cistostomía suprapúbica por punción, idealmente guiada por ecografía, y estudio posterior con uretrografía retrógrada

Respuesta E. Sangre en el meato y hematoma perineal tras caída a horcajadas sugieren lesión de uretra bulbar: está contraindicado el sondeo transuretral. Con globo vesical palpable, la vejiga se drena mediante cistostomía suprapúbica por punción, y la uretra se estudia con uretrografía retrógrada.

4.03.5.005 Instalación y cuidado de sonda Foley

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 13.2 Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones de sonda Foley: retención urinaria sin trauma, medición de diuresis horaria en paciente crítico, cirugía prolongada, hematuria con coágulos (sonda 3 vías 20–24 Fr). Contraindicada si hay sospecha de lesión uretral.
- Técnica: aséptica; en el hombre lubricar con lidocaína gel 2%, calibre 16–18 Fr, avanzar sin forzar hasta la bifurcación y solo tras ver salir orina inflar el balón con agua destilada (10 mL).
- Inflar el balón en la uretra causa dolor, sangrado y falsa vía; ante resistencia o sangre en el meato no forzar (cistostomía).

- Cuidados: sistema cerrado, bolsa bajo el nivel vesical, reponer el prepucio (evitar parafimosis) y retirar apenas no se necesite; no indicar profilaxis antibiótica ni tratar la bacteriuria asintomática.
- Retención crónica con >1.000 mL evacuados: descompresión continua y vigilar diuresis postobstructiva y potasio.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Hombre de 70 años hospitalizado por neumonía requiere sonda Foley para medir diuresis horaria. Al instalarla, después de introducir unos 10 cm, aún no sale orina. **Respecto de la técnica y cuidados de la sonda Foley, ¿cuál afirmación es correcta?**
>
> **A)** Inflar el balón en cuanto se sienta resistencia, para fijarla
> **B)** Mantener la bolsa sobre el nivel de la vejiga para facilitar el drenaje
> **C)** Cambiar la bolsa abriendo el sistema cada 8 horas para evitar infecciones
> **D)** Introducir la sonda hasta la bifurcación y verificar la salida de orina antes de inflar el balón con agua destilada, con técnica aséptica y sistema de drenaje cerrado
> **E)** Indicar profilaxis antibiótica permanente mientras dure la sonda
>
> Respuesta D. En el hombre se lubrica con lidocaína en gel, se introduce la sonda hasta la bifurcación y solo después de ver orina se infla el balón, para no inflarlo en la uretra. Se usa técnica aséptica, sistema cerrado, bolsa bajo el nivel vesical y se retira apenas no se necesite. La profilaxis antibiótica no está indicada.

4.03.5.006 Reducción de parafimosis

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: uro-16

QUÉ HAY QUE SABER

- Parafimosis: prepucio retraído que forma anillo constrictor detrás del glande, con edema; urgencia por riesgo de isquemia.
- Preparación: analgesia (bloqueo peneano dorsal o anestesia tópica) y explicar el procedimiento.
- Técnica: compresión manual sostenida del glande por varios minutos para reducir el edema; luego empujar el glande con ambos pulgares mientras los dedos índice y medio traccionan el anillo prepucial hacia distal.
- No aplicar calor; si la reducción fracasa o hay necrosis, derivar para incisión dorsal del anillo.
- Tras la reducción: control del edema y derivar para circuncisión electiva.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Niño de 10 años con parafimosis de 3 horas tras retraer el prepucio al bañarse. Glande edematoso, rosado, con anillo constrictor retraído. Se decide reducción manual en urgencia. **¿Cuál es la técnica adecuada?**
>
> **A)** Tirar del prepucio hacia adelante sin preparar el glande
> **B)** Analgesia, compresión manual sostenida del glande para reducir el edema, y luego empujar el glande con los pulgares mientras los índices y medios traccionan el prepucio hacia distal
> **C)** Incisión dorsal del prepucio como primera medida
> **D)** Aplicar calor local y esperar reducción espontánea
> **E)** Indicar corticoide tópico y control en 1 semana
>
> Respuesta B. La reducción manual de la parafimosis requiere analgesia (bloqueo peneano o anestesia tópica), compresión sostenida del glande para disminuir el edema y luego presión del glande con los pulgares mientras los dedos índice y medio llevan el anillo prepucial sobre él. Si falla, se realiza incisión dorsal. El calor aumenta el edema.